

REPUBLIQUE DE SENEGAL

Un Peuple, un But, une Foi



DRAFT DE PLAN D'EVALUATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 2005 NOVEMBRE 2011

Version du 06 décembre 2011

Sommaire

Liste des membres de l'Equipe d'Evaluation	1
Abréviations et Acronyme.....	3
Résumé du rapport.....	5
1-INTRODUCTION	6
2-CONNAISSANCES DE BASE SUR LE PAYS.....	7
2.1-Géographie.....	7
2.2-Démographie.....	8
2.2-Indicateurs Socio-économique et de l'état de santé	8
2.4- Le fardeau des maladies transmissibles, des risques chimiques et radiologiques	10
2.4.1-Les maladies transmissibles	10
2.4.2-Les risques chimiques	11
2.4.2.1. Analyse de la situation	12
2.4.2.2- Instruments juridiques, mécanismes non juridiques et implication au niveau international.....	13
2.4.2.3- Mesures concrètes et progrès réalisés	16
2.4.2.4. Enseignements tirés et bonnes pratiques	23
2.4.2.5- tendances et questions émergentes.....	24
2.4.2.6- Contraintes, défis et perspectives.....	26
2.4.2.7- Etudes de cas ou pratiques de référence.....	30
2.4.3-Les risques radiologiques	31
2.5-Système de santé	32
2.5.1-Organigramme du ministère chargé de la santé.....	32
2.5.2-Distribution des services de santé	32
2.5.3-Ressources humaines.....	33
2.5.4-Financement de la santé	36
2.6-Survol de la surveillance et réponse	39
2.6.1-Risques et maladies prioritaires.....	39

2.6.2-Procédures de notification.....	40
2.6.3-Confirmation des événements.....	40
2.6.4-Réponse.....	40
2.6.5-Activités de surveillance dans le secteur privé	41
3-OBJECTIFS DE L'EVALUATION	41
4-METHODOLOGIE	41
4.1-Descente sur le terrain.....	41
4.2-Analyse des données.....	42
4.3-Formation et rétroaction	42
5-RESULTATS DE L'EVALUATION	43
5.1-Législation Nationale, Politique et Finances	43
5.2-Coordination et Communications au Point Focal National RSI.....	45
5.3-Surveillance	46
5.4-Réponse.....	47
5.5-Préparation	48
5.6-Communication de risque	50
5.7-Ressources humaines.....	51
5.8-Laboratoires	52
5.9-Evénements zoonotiques.....	53
5.10-Sécurité Sanitaire Alimentaire	54
5.11-Evénements chimiques	55
5.12-Urgences radionucléaires.....	56
5.13-Points d'entrée	57
5-RECOMMANDATIONS	59
6-PERSPECTIVES.....	59
7-ANNEXES	59
8-PLAN D'ACTION	60

Liste des membres de l'Equipe d'Evaluation

Prénom (s) et Nom	Service
Abdoulaye DIAW	DPM/MSHPP
Aboubacry FALL	DPM/ MSHPP
Absa LAM	CAP/MSHPP
Alain DIEDHIOU	CTAJ/MSHPP
Aliou POUYE	C. Sanitaire Aéroport/MSHPP
Amadou KANOUTE	MI COM
Aminata BA NDIAYE	MINT
Babacar NDIAYE	MICITIE
Bienvenu G.R. NIOUKY	M.F.A
Binetou YADE	DES /MSHPP
Coumba Faye DIOUF	DSV/MEL/BPC
Daouda DIOP	PNA/MSHPP
Dié Thiam DIAITE	DPL /MSHPP
Djib NGOM	SNH/MSHPP
Ibra Samba Yoro DIOP	Ministère Justice
Ibrahim Oumar BA	DPM/MSHPP
Kader NDIAYE	IPD
Lam Toro Mamadou SECK	PNA/MSHPP
Lamine DIAWARA	OMS /Dakar
LO Baïdy BOUBOU	OMS
Malang COLY	OMS / Dakar
Malick CISSE	IAAF/MSHPP
Malick NDIAYE	SNEIPS/MSHPP
Mame Diarra FAYE	MINT/ECO/Maritime
Mame Sine Mbodji Ndiaye	ASN/MMITAPME

Prénom (s) et Nom	Service
Mohamed ND. SANGARE	DS/MSHPP
Moussa DIENE	MTTTF AT/CT
Moussa DIOUF	C.S.F.M .PAD
Moustapha Sadibou TALL	ARSN
Omar SARR	CT/3 .MSHPP
Sidy NDIAYE	DCI/MCOM

Abréviations et Acronyme

AIEA	: Agence Internationale de l'Energie Atomique
BPL	: Bonne Pratiques de Laboratoire
CEDEAO	: Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CFC	: Chlororofluocarbure
CHS	: Comité d'Hygiène et de Sécurité
CLV	: Comités de Lutte Villageois
CNGPC	: Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques
COP	: Conférences des Parties
CSP	: Comité Sahélien des Pesticides
DOD	: Demande d'Aide à la Décision
DRH	: Direction des Ressources Humaines
EDS	: Enquête Démographique et Sanitaire
FAO	: Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
FAR	: Femmes en Age de Reproduction
FFOM	: Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
FISC	: Comité Intergouvernemental sur la Sécurité Chimique
GIPD	: Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs
GOANA	: Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance
NEPAD	: Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique
OMD	: Objectifs du Millénium pour le Développement
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
OMVS	: Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
PCB	: Polychlorobiphényles
PGEF	: Plan de Gestion de l'Elimination des fluides frigorigènes
Plan ORSEC	: Plan d'Organisation des Secours
PNDS	: Plan National de Développement Sanitaire

POCL	: Plan Opérationnel des Collectivités Locales
POI	: Plan d'Opération Interne
POPs	: Polluants Organiques Persistants
PTIP	: Programme Triennal d'Investissement Public
QSP	: Quick Start Program
QUEST	: Programme de contrôle de la qualité des traitements anti-acridiens
RSI	: Règlement Sanitaire International
SAICM	: Stratégie sur la Gestion Internationale des Produits Chimiques
SAO	: Substances Appauvrissant la couche d'Ozone
SCA	: Stratégie de Croissance Accélérée
SGH	: Système Général Harmonisé d'Etiquetage et Classification
UE	: Union Européenne
UEMOA	: Union Economique Ouest Africaine

Résumé du rapport

1-INTRODUCTION

Le Règlement Sanitaire International (RSI) est un instrument juridique international qui a force obligatoire pour 194 pays dont le Sénégal. Adopté par l'Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005, il est entré en vigueur le 15 juin 2007. Son objectif est de "*prévenir la propagation internationale des maladies, s'en protéger, la maîtriser et y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux*".

Aux termes des articles, 5 et 13 du RSI chaque Etat devrait acquérir, renforcer et maintenir les compétences requises dès que possible mais au plus tard dans les cinq (05) ans suivant l'entrée en vigueur du RSI (15 juin 2012).

Les Etats ont pris l'engagement d'évaluer leurs capacités entre 2007 et 2009 et de mettre en place des plans d'action de mise en œuvre des capacités principales pour la période 2009-2012.

La réunion de Brazzaville, organisée en août 2011, a constaté que sur les quarante six (46) pays Africains, près de la moitié n'a pas développé un plan d'action pour la mise en œuvre de ces capacités. Pour permettre aux Etats de s'acquitter de leurs obligations, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) branche AFRO a élaboré un guide pour accélérer l'application du RSI et permettre aux pays membres d'avoir une prorogation de délai jusqu'en 2014.

C'est dans ce sens que, le Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Prévention a organisé deux (02) ateliers multisectoriels pour initié l'évaluation du RSI qui se sont soldé par la rédaction du présent rapport.

2-CONNAISSANCES DE BASE SUR LE PAYS

2.1-Géographie

Situé à l'Ouest du continent Africain (entre les 12,5 et 16,5 degrés de latitude Nord), le Sénégal s'étend sur 196.722 km², limité au Nord par la Mauritanie, à l'Est par le Mali, au Sud par la Guinée et la Guinée Bissau. Le pays est divisé en 14 régions, 45 départements, 121 arrondissements, 113 communes, 46 communes d'arrondissement et 370 communautés rurales englobant les villages.



Carte 1 : Le Sénégal, localisation géographique

Le climat est du type soudano sahélien avec une saison sèche allant de novembre à juin et une saison des pluies de juin à octobre. La pluviométrie annuelle passe de 300 mm au Nord du Pays quasi désertique à 1200 mm dans le Sud.

2.2-Démographie

La population est estimée en 2011 à 12 .862. 587 habitants avec un taux d'accroissement annuel de 2,7 %. Le taux de natalité est de 39 ‰ alors que l'indice synthétique de fécondité est estimé à 5,3 enfants par femme¹. Le Sénégal a l'un des taux d'urbanisation les plus élevés d'Afrique noire (DPS 2005). La population est jeune avec environ 50 % de moins de 16 ans. Les enfants de 0 à 5 ans représentent 19,4 % de la population totale.

2.2-Indicateurs Socio-économique et de l'état de santé

L'économie du Sénégal continue de faire face à diverses contraintes parmi lesquelles on peut citer un environnement des affaires peu attractif et la dépendance de la production agricole à la pluviométrie. Afin de lever ces obstacles, le Sénégal a mis en œuvre des stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté² depuis 2001 avec un objectif de taux de croissance de 7 à 8% pour réduire de moitié la pauvreté en 2015 et atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et ceux du Programme National de Développement Sanitaire 2009-2018 (PNDS2009-2018). Dans ce cadre, des politiques sectorielles vigoureuses, telles que la fourniture de services sociaux (éducation, santé, accès à l'eau potable, assainissement, etc.), le programme de réforme des finances publiques, la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA), la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance (GOANA), etc. sont progressivement mises en place en vue de relever significativement les performances socio-économiques et placer le pays sur un sentier de développement humain durable. Il importe de noter, à cet effet, une politique d'amélioration de la gestion des finances publiques grâce à une affectation stratégique des ressources, une transparence dans l'exécution des dépenses publiques et une effectivité des

¹ Enquête Démographique et Sociale numéro 5 (EDS IV)

² Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté 1 et 2 (DSRP 1 & 2)

contrôles interne et externe. C'est ainsi que d'importants résultats au plan économique et financier ont été enregistrés au cours de ces dernières années. En effet, la croissance économique réelle s'est située en moyenne autour de 5% par an dans un contexte de maîtrise de l'inflation et des autres fondamentaux de l'économie. L'inflation moyenne annuelle sur la période 2000-2006 s'est située à 2%, inférieure à celle des partenaires de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), grâce notamment à une politique budgétaire et monétaire vertueuse et à un approvisionnement adéquat des marchés. La gestion budgétaire a été caractérisée par un bon niveau de recouvrement des recettes fiscales et une gestion prudente des dépenses budgétaires. En effet, les recettes fiscales ont progressé de 9% en moyenne annuelle sur la période, ce qui s'est traduit par une hausse continue de la pression fiscale passant de 16,1% en 2000 à plus de 19 % en 2006, nonobstant la baisse du taux d'imposition des sociétés. Les dépenses budgétaires ont, quant à elles, évolué en ligne avec les priorités déclinées dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, avec notamment un accent dans les secteurs sociaux de base (éducation et santé) et les secteurs productifs. En effet, les secteurs de l'éducation et de la santé absorbent depuis 2004 plus de 50% du budget de fonctionnement.

Les principaux indicateurs sanitaires de l'Enquête Démographique et Sanitaire numéro 4 (EDS IV), portant sur l'année 2005, montrent que des progrès ont été réalisés mais que l'état de santé de la mère et de l'enfant reste préoccupant :

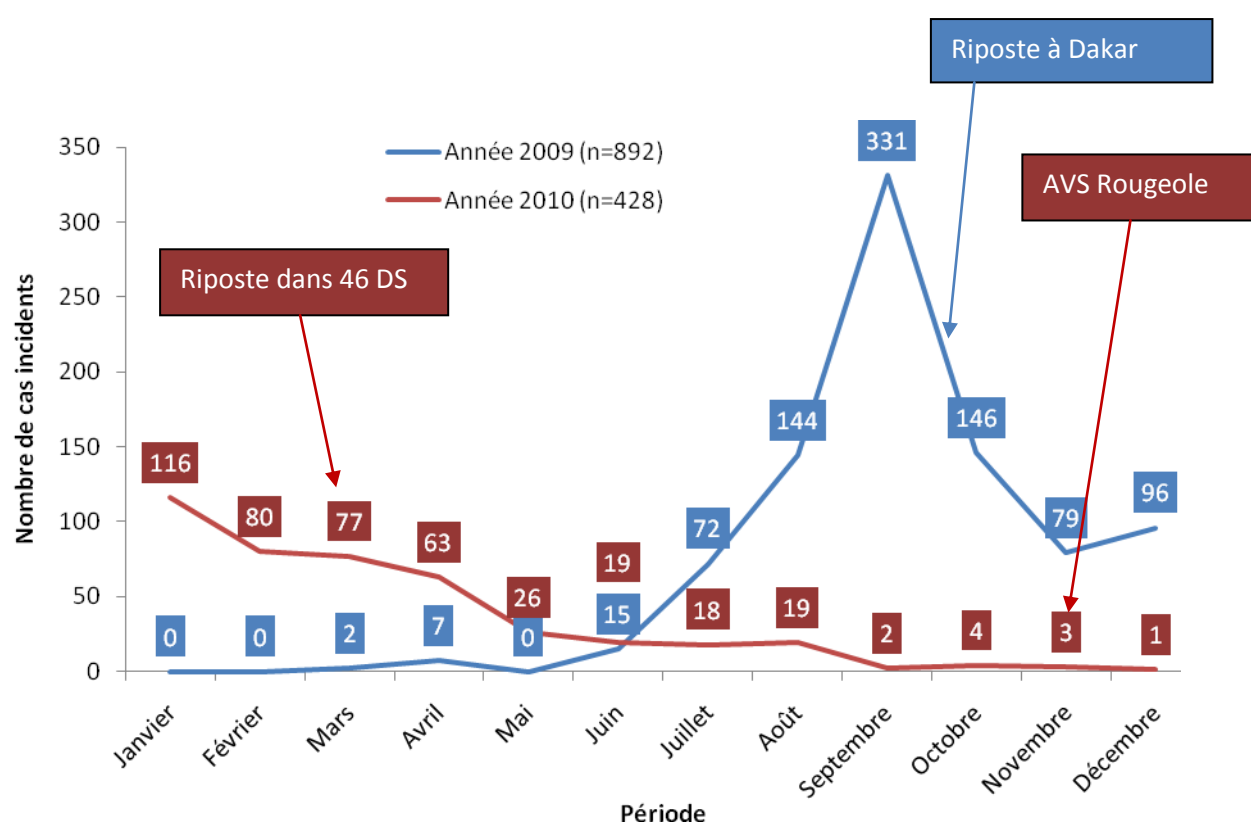
- Taux de mortalité maternelle : de 434 pour 100.000 naissances vivantes (309 en zone urbaine contre 472 en zone rurale) ;
- Taux de mortalité infantile : 61 ‰ (52 en Zone urbaine contre 82 en Zone rurale) ;

- Taux de mortalité infanto juvénile : 121 ‰ (91 en zone urbaine contre 160 en zone rurale).

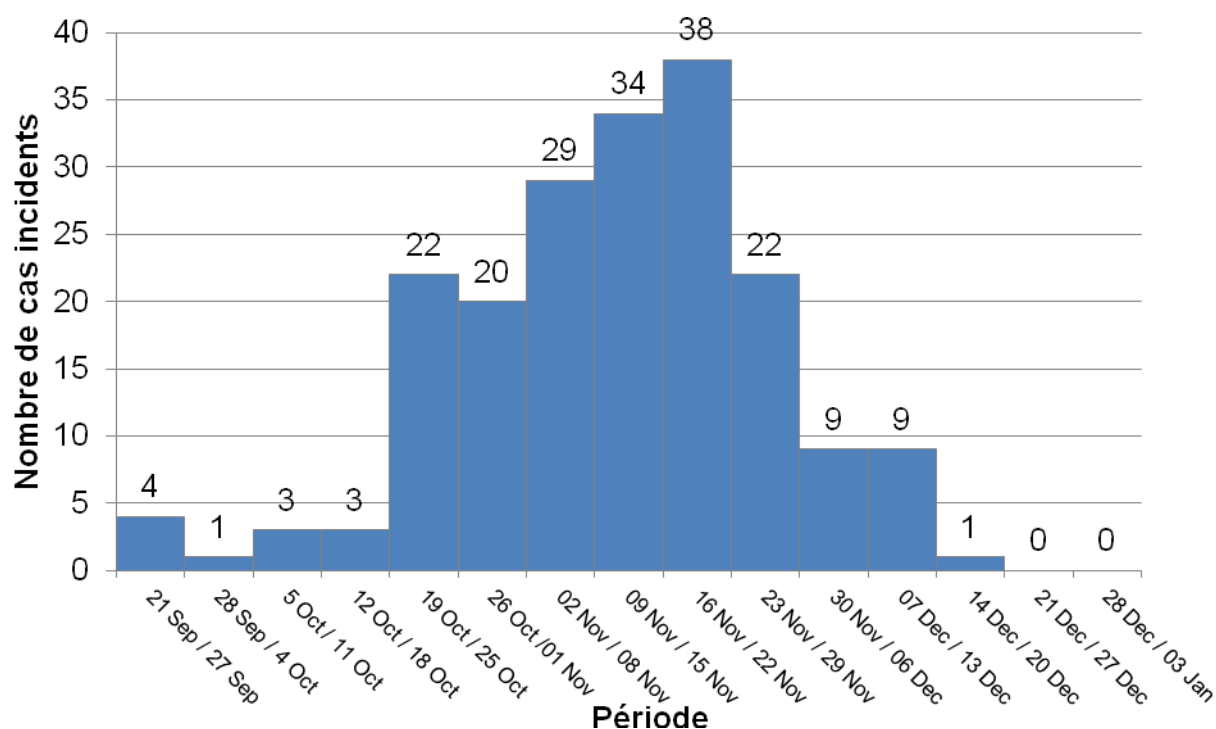
2.4- Le fardeau des maladies transmissibles, des risques chimiques et radiologiques

2.4.1-Les maladies transmissibles

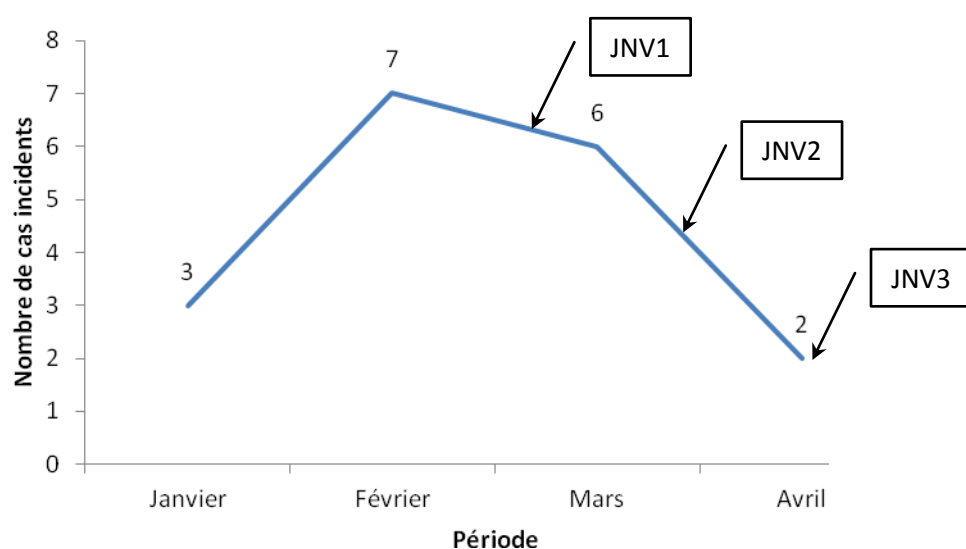
Les maladies transmissibles constituent une préoccupation majeure au Sénégal. Les années 2009 et 2010 ont été émaillées de flambées épidémiques. En 2009, 892 cas de rougeole ont été confirmés par le laboratoire ou par un lien épidémique, de même que 194 cas de Dengue de type 3. En 2010, 325 cas de grippe pandémique ont été notifiés plus dix huit (18) cas de poliomyélite de type 1.



Graphique 1 : Évolution des cas confirmés (par laboratoire ou lien épidémiologique) de rougeole, Sénégal, année 2009 vs année 2010



Graphique 2 : Évolution des cas confirmés de Dengue 3, Sénégal, année 2009



Graphique 3 : Évolution des cas confirmés de poliomyélite de type 1, Sénégal, année 2010

2.4.2-Les risques chimiques³

Le Sénégal, dans le cadre de sa politique de développement durable, accorde une place importante à la gestion des produits chimique. A ce titre, il a mis en place des stratégies de

³ Sources : http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_pdfs/NationalReports/senegal/gestion_des_produits_chimiques.pdf

réponse aux plans institutionnel, juridique, infrastructurel, financier et informationnel en vue de mettre en œuvre les conventions internationales et de s'adapter aux changements intervenus au niveau mondial en la matière.

Dans le cadre de ce rapport, la situation de référence est l'année 2002, date de la dernière réactualisation du profil national du Sénégal sur la gestion des produits chimiques. Pour évaluer les progrès réalisés, identifier les contraintes et les perspectives et enfin, les principaux défis à relever à l'échelle nationale, sous – régionale et régionale.

2.4.2.1. Analyse de la situation

Le diagnostic de la situation du pays en matière de gestion des produits chimiques avait permis de déterminer globalement :

- les données sur la production, l'importation, l'exportation et l'utilisation des produits chimiques et les problèmes prioritaires afférents à leur usage dans les activités de développement ;
- les instruments juridiques et mécanismes non réglementaires mis en place et les implications au niveau international ;
- les capacités techniques et les ressources disponibles ;
- les aspects informationnels.

Au Sénégal, les produits chimiques sont utilisés dans plusieurs secteurs parmi lesquels :

- **l'agriculture**, où ils servent d'intrants agricoles (pesticides, engrais) ;
- **les industries** avec plus d'une centaine d'entreprises industrielles en 2001 qui les utilisent comme matières premières ou les produisent ;

- **la santé publique et/ ou la santé animale**, comme désinfectants et/ou médicaments;

Le commerce des produits chimiques équivaut à un marché intérieur de cent vingt et un (121) milliards de francs CFA par an. Dans ce marché, le secteur industriel joue un rôle important, notamment avec des entreprises de production d'acide phosphorique, d'engrais et de formulation de pesticides agricoles et sanitaires.

Les problèmes qui avaient été identifiés dans le cadre du profil national se résument aux cas d'empoisonnement causés par les résidus de pesticides dans les aliments, aux atteintes à la santé en milieu professionnel et rural, à la gestion des déchets dangereux issus de l'utilisation des produits chimiques et aux accidents industriels.

2.4.2.2- Instruments juridiques, mécanismes non juridiques et implication au niveau international

Déjà en 2002, le Sénégal avait ratifié plusieurs conventions internationales relatives aux produits chimiques. Il s'est doté également de textes nationaux pour les prendre en compte dans son droit positif et renforcer son arsenal juridique en la matière.

a) Aperçu sur les textes internationaux

Parmi les conventions et instruments relatifs aux produits chimiques, nous pouvons citer :

- la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (ratifiée en mars 1985) et le Protocole de Montréal (ratifié en mai 1993) ;
- la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ratifiée en juillet 2001) ;
- la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants signée en mai 2001 et ratifiée en octobre 2003 ;

- la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction signée le 13 janvier 1993 et ratifiée le 25 mars 1998 ;
- la Réglementation Commune du CILSS sur l'homologation des pesticides signée en 1990 et ratifiée en 2002 ;
- la Convention BIT n° C013 contre l'emploi de la céruse dans la peinture ;
- Le Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) de 1985 ;
- Le Code d'Ethique sur le commerce international des produits chimiques d'avril 1994 sur les principes et directives du secteur privé pour l'application de règles de conduite visant à gérer rationnellement les produits chimiques.

b) Dispositif légal et réglementaire national

Au niveau national, la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l'environnement est le principal instrument juridique en matière de gestion des produits chimiques. Il pose le principe d'une gestion écologiquement rationnelle desdits produits en intégrant les conventions internationales auxquelles le Sénégal a souscrit. Ce code introduit dans notre droit positif, la systématisation de l'évaluation environnementale préalable qui sous-tend les autorisations relatives aux activités ayant trait à l'usage des produits chimiques. Il renforce aussi la gestion des risques d'accidents chimiques en mettant à niveau la législation sur les installations classées. Le code est complété par un décret d'application n° 2001 -282 du 12 avril 2001 qui réglemente les modalités de gestion des produits chimiques.

Il est important de souligner que l'une des innovations majeures du Code de l'environnement est la consécration d'une Commission nationale de Gestion des Produits

Chimiques (CNGPC)⁴, qui est une plateforme institutionnelle de coordination dans ce domaine.

L'autre innovation importante est la consécration d'une réglementation basée sur une approche cycle de vie du produit chimique, qui prend en compte toutes les étapes allant de la production à l'importation, à l'élimination et au recyclage.

Notons aussi que ladite loi, en prenant en compte les grandes orientations stratégiques définies au niveau international, abrogeait certaines dispositions de la loi n° 84-14 du 02 février 1984 qui ne concernait que les spécialités agro pharmaceutiques et assimilés.

D'autres textes législatifs et réglementaires ont été pris aussi pour assurer une meilleure gestion des risques liés aux produits chimiques, notamment :

- la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail en son titre XI relatif à l'hygiène et à la sécurité et ses textes d'application ;
- la loi 73-37 du 31 juillet 1973 portant code de la sécurité sociale en son chapitre IV titre II et ses textes d'application ;
- l'arrêté interministériel n°04862/MEPN/MEMI/M.INT du 14 juillet 1999 rendant obligatoire le Plan d'Opération Interne (POI).

Le dispositif réglementaire est complété par des normes techniques parmi lesquelles on peut citer :

- la norme NS 03-045 sur le taux admissible de cadmium dans les produits de la pêche et la méthode de détermination ;

⁴ La CNGPC a été consacré par le Code en son article L 45. Elle a été créée par arrêté ministériel n° 000852 du 08 février 2002.

- la norme NS 03-046 sur le taux admissible de mercure dans les produits de la pêche et la méthode de détermination ;
- la norme NS 03-047 sur le taux admissible d'anhydride sulfureux dans les produits de la pêche et la méthode de détermination.

2.4.2.3- Mesures concrètes et progrès réalisés

Au regard des problématiques majeures⁵ liées au cycle de vie des produits chimiques, le Sénégal a réalisé un certain nombre de progrès axés principalement sur la réglementation, le renforcement des capacités techniques et financières et la sensibilisation des différentes parties prenantes. Pour une bonne coordination de toutes ces actions, des orientations stratégiques ont été définies dans le cadre de la mise en œuvre des conventions internationales sur les produits chimiques. Ces mesures contribuent à limiter voire éliminer les risques liés aux produits chimiques dans le but de protéger l'environnement et la santé humaine.

a) Orientations stratégiques en matière de gestion de produits chimiques

En terme de planification stratégique, voire opérationnelle pour la mise en œuvre des conventions sur les produits chimiques, le Sénégal a élaboré les documents de référence ou outils d'aide à la décision suivants :

- le profil national de gestion des produits chimiques de décembre 2002 ;
- le profil national sur la gestion des Polluants organiques persistants (POPs) de janvier 2004; l'inventaire national des Polychlorobiphényles (PCB) de mars 2003 ;

⁵ Intoxications humaines, présence de résidus de pesticides dans les aliments, problèmes de santé, d'élimination des déchets dangereux, accidents chimiques industriels, etc.

- le plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les POPs de 2005;
- le plan de Gestion de l'Élimination Finale des fluides frigorigènes (PGEF) de novembre 2007 ;

b) Renforcement du cadre juridique et mesures d'application

✓ Au niveau national

Le Sénégal a renforcé son arsenal juridique en matière de gestion du cycle de vie des produits chimiques, en particulier des POPs pour adapter sa politique de maîtrise des risques chimiques à une situation sans cesse évolutive, eu égard à des comportements nouveaux liés à la pauvreté et à la mondialisation des échanges.

Ainsi, l'arrêté primatorial n°09415 du 06 novembre 2008 interdit l'importation, la production et l'utilisation des pesticides et des produits chimiques visés par la Convention de Stockholm sur les POPs.

De même des textes réglementaires sur l'usage des substances appauvrissant la couche d'ozone complète ce dispositif (décret 2000- 73 du 31 janvier 2000 portant réglementation de la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone et arrêté interministériel n° 08874 du 08 novembre 2001 réglementant la consommation desdites substances).

Il est important de noter que ces mesures réglementaires ont permis de réduire de 95% la consommation sénégalaise en CFCs entre 1994 et 2008, ceci grâce à une gestion rigoureuse d'attribution de quotas.

On peut souligner, par ailleurs, qu'un processus de mise à niveau de la législation nationale sur les produits chimiques est en cours d'élaboration. Le but visé est de renforcer la gestion intégrée des produits chimiques, de compléter et de préciser les dispositions générales contenues dans le code de l'environnement pour mieux prendre en charge les priorités nationales et les questions émergentes en la matière.

D'une manière spécifique, et pour répondre à l'utilisation incontrôlée de certaines spirales anti-moustiques réputées nocives pour la santé humaine, un projet d'arrêté interministériel relatif à l'interdiction d'importer, d'exporter, de formuler et de distribuer celles contenant de l'Octachlorodipropyl Ether (S 421) a été élaboré.

✓ **Aux niveaux sous-régional, régional et international**

Le Sénégal a ratifié en 2002 l'accord relatif à la réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur l'homologation des pesticides. Il a, par ailleurs, interdit la distribution et l'utilisation de l'endosulfan respectivement en 2007 et 2008, conformément à la décision prise par le Comité sahélien des Pesticides (CSP). Cette mesure a été notifiée au Secrétariat de la Convention de Rotterdam. Conformément à cette dite convention, il a notifié des réponses d'importation pour trente et un (31) produits chimiques sur les quarante et un (41) inscrits sur la liste des produits soumis à la procédure du consentement préalable.

Une notification faite au secrétariat de la Convention de Rotterdam a fait l'objet d'un Document d'aide à la décision (DOD) adopté par la Conférence des Parties. Ce DOD a permis l'inscription de deux (02) préparations de pesticides extrêmement dangereuses sur la liste PIC. Il s'agit du Granox TBC et du Spinox T.

Par ailleurs, le Sénégal a adopté, conformément à la Convention internationale sur les armes chimiques, la loi n° 2006 – 36 portant sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication,

du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, dans laquelle est déterminée la liste des produits concernés.

c) Renforcement des capacités techniques et financières

Dans ce volet, le Sénégal a surtout amélioré ses infrastructures techniques destinées à la production de données et à la toxico-vigilance et, mené une politique de formation des différentes parties prenantes. L'Etat a aussi soutenu financièrement des institutions techniques.

Le Sénégal disposait en 2002 d'un parc de laboratoires relativement important ayant des capacités en matière de contrôle et de suivi environnemental des produits chimiques. Ces laboratoires sont répartis entre l'administration publique, le secteur privé et celui de l'enseignement et de la recherche. Ces laboratoires ont des capacités analytiques développées. Ils se sont inscrits dans une démarche qualité grâce à l'accréditation et à l'adoption des Bonne Pratiques de Laboratoire (BPL). Par ailleurs, le Sénégal a acquis en 2006 un laboratoire mobile pour le contrôle de la qualité de l'air.

En application de la résolution du 3ème Forum du Comité Intergouvernemental sur la Sécurité Chimique (FISC), il a aussi été créé un Centre Anti-Poison. Ce centre a pour principale mission d'assurer la prévention des intoxications causées par les xénobiotiques, notamment les pesticides et les produits chimiques industriels et, l'amélioration de leur prise en charge et la surveillance de leurs effets sur la santé humaine.

Dans cette même optique, le Centre régional de Recherches en Eco-toxicologie et Sécurité Environnementale, dénommé "Fondation CERES-Locustox", reconnue d'utilité publique, par le décret n° 99-1297 du 31 décembre 1999, a développé des capacités d'évaluation des résidus de pesticides et des POPs dans les matrices prioritaires, dont le lait maternel. Cette

maîtrise technique positionne cette structure d'expertise comme un laboratoire de référence au niveau sous-régional, voire régional. Ses capacités techniques peuvent être capitalisées dans le cadre de l'évaluation mondiale des POPs.

Egalement, le Sénégal en se basant sur une expertise nationale, a réalisé une cartographie des risques d'accidents majeurs sur l'ensemble du territoire national. Cette cartographie prend en compte les risques toxiques liés à l'utilisation de substances chimiques dangereuses comme le chlore et l'ammoniac.

En matière de formation, il faut souligner la tenue d'ateliers techniques relatifs aux trois (03) conventions sur les produits chimiques et au Système Général Harmonisé d'Etiquetage et de Classification (SGH). Ces formations ont été réalisées au profit de la Commission nationale de Gestion des Produits Chimiques pour lui permettre de jouer son rôle avec efficacité.

Cependant, l'une des cibles prioritaires en matière de renforcement des capacités techniques a été l'administration douanière, eu égard à sa mission de contrôle de l'entrée des produits chimiques sur le territoire national. C'est dans ce cadre que des ateliers de formation sur le contrôle des CFC et sur la nomenclature internationale sur les POPs ont été organisés au profit des douaniers.

Soulignons qu'en entreprise, les Comités d'Hygiène et de Sécurité (CHS) constituent un cadre de formation et d'éducation des travailleurs.

En matière de mobilisation de ressources financières internes, des avancées ont été notées. Par exemple, le Ministère chargé de l'Environnement a bénéficié de ressources relativement importantes pour promouvoir le rôle du Sénégal et de l'Afrique dans la gouvernance mondiale des produits chimiques, à travers l'organisation de deux (02) Conférences des

Parties (COP) respectivement pour la Convention de Stockholm et celle de Vienne et de son protocole sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO).

d) Mesures d'accompagnement

Les mesures d'accompagnement qui ont été mises en œuvre concernent particulièrement la sensibilisation des acteurs pour asseoir une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques, la recherche et la promotion d'alternatives durables.

Des ateliers de sensibilisation et d'information à l'attention de la société civile et de la presse ont été tenus par l'administration sur les aspects suivants :

- les risques d'accidents ;
- la réutilisation du DDT ;
- les accords internationaux ;
- le SGH.

Quant au secteur privé, il a organisé des ateliers de formation pour les journalistes et les distributeurs de pesticides sur la législation.

Concernant les POPs, un dépliant et un film documentaire ont été élaborés à l'attention du grand public. De même, une étude socio-économique sur l'utilisation des POPs a été réalisée en novembre 2004, pour faciliter une meilleure prise de décision des autorités en matière de réglementation.

La mise en place d'un réseau d'échange d'informations sur les produits chimiques et la création d'une page Web constituent également l'une des actions transversales les plus pertinentes, au regard des lacunes constatées dans le domaine du partage et de la centralisation des données.

De même, en vertu de la sauvegarde des ressources en sols, le Sénégal promeut la gestion durable des terres. Cette politique est menée à travers le développement de techniques

avérées de fertilisation raisonnée, la diffusion des meilleurs usages à faire des engrais chimiques et le contrôle de leur qualité.

e) Initiatives aux niveaux sous – régional et régional et leadership dans la gouvernance des produits chimiques

Le Sénégal participe activement à la concertation sous – régionale (CEDEAO/UEMOA) pour amener les Etats à harmoniser leurs politiques commerciales et environnementales en matière de gestion des produits chimiques. Il accorde une priorité à cette initiative compte tenu de la porosité des frontières et de la place de ses infrastructures portuaires dans le commerce sous-régional, voire international.

Dans cette même logique, le Sénégal est partie prenante au processus d’harmonisation sous-régionale avec l’intégration du SGH dans le volet étiquetage et emballage du dossier d’homologation du CSP. Il est particulièrement favorable à cette harmonisation car il se prépare à appliquer le SGH or, sans cette mise en synergie, ce système risquerait de perdre son efficacité.

Concernant la gestion écologiquement rationnelle des PCBs, notre pays a pris part au « Projet Régional des PCBs ». Ce projet avait pour objectifs de réduire les risques environnementaux et de santé publique dus à l’exposition aux rejets de PCBs dans quatorze (14) pays⁶ d’Afrique de l’Ouest.

En matière de gouvernance régionale et internationale dans le domaine de la gestion des produits chimiques, le Sénégal a eu à présider la COP à la Convention de Stockholm sur les POPs et celle de Vienne sur les SAO, ainsi que la rencontre des parties au Protocole de Montréal en 2005. Il a également abrité une rencontre du Forum Intergouvernemental sur la

⁶ Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo.

Sécurité Chimiques (FISC) et une autre sur l'Approche Stratégique sur la Gestion internationale des Produits chimiques (SAICM). Le Sénégal a aussi obtenu le prix du meilleur Bureau Ozone en 2003 en même temps que les Iles Fidji, la Jamaïque et la Chine.

L'engagement du Sénégal a permis de mieux défendre et de faire valoir les priorités africaines relatives à la mise en œuvre des « conventions chimiques ». Ce leadership s'est affirmé par l'intégration de la problématique de la gestion des produits chimiques dans l'Initiative environnementale du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD).

Présentement, le Sénégal assure la vice-présidence du Bureau de la Conférence Internationale sur la Gestion des Produits Chimiques.

2.4.2.4. Enseignements tires et bonnes pratiques

La problématique de l'utilisation raisonnée et à grande échelle de produits de diverse nature a montré la nécessité de mettre en place des cadres de concertation pour mieux appréhender la question de la sécurité chimique. C'est ainsi que ces dernières années, l'Etat du Sénégal a beaucoup investi dans la formation et la communication. A titre d'exemple, on peut citer dans le cadre de l'évaluation des stratégies d'exposition et de surveillance de l'environnement, la création d'une cellule de suivi environnemental des traitements phytosanitaires contre les criquets pèlerins. Cette cellule a pour mission de surveiller l'environnement après les traitements chimiques contre ces ravageurs. Elle regroupe des spécialistes en la matière : médecins, vétérinaires, toxicologues, éco-toxicologues biologistes, environnementalistes, pédologues, etc.

Par ailleurs, la formation des utilisateurs est un point important. Dans les politiques et les cadres pour la prévention des accidents liés aux produits chimiques, le département de l'agriculture a institué une formation permanente de tous les acteurs des interventions

chimiques sur l'ensemble du territoire (membres des Comités de Lutte Villageois (CLV), chauffeurs, applicateurs, baliseurs). Un plan de communication à l'intention des populations des zones traitées a été aussi déroulé.

2.4.2.5- tendances et questions émergentes

A ce niveau, trois (03) domaines prioritaires peuvent être explorés, à savoir :

- la gestion intégrée à travers la SAICM ;
- la synergie entre les Conventions de Rotterdam, de Stockholm et de Bâle ;
- la gestion des substances toxiques.

a) La gestion intégrée à travers l'Approche stratégique sur la Gestion internationale des produits chimiques (SAICM)

Concernant la SAICM, le Sénégal mène des efforts importants pour mobiliser des ressources pour son opérationnalité aux niveaux national et sous-régional. C'est ainsi qu'un projet national relatif à la réactualisation de son profil national de gestion des produits chimiques et un projet avec le Mali sur les risques d'accidents chimiques sont en instruction au niveau du Quick Start Program (QSP). Ce dernier projet sous-régional vient renforcer le projet d'Appui au Programme National de Prévention, de Réduction des Risques majeurs et de Gestion des Catastrophes naturelles au Sénégal dans le contexte de la Réduction de la Pauvreté, qui intègre un volet sur les risques technologiques, en particulier les risques chimiques.

b) La synergie des conventions sur les produits chimiques

Dans le domaine de la synergie, nous pouvons noter une réelle volonté de prise en charge des déchets dangereux liés à une utilisation rationnelle des produits chimiques. C'est ainsi que quatre cent vingt neuf (429) tonnes de pesticides périmés, des contenants souillés et

des sols contaminés ont été collectés, transportés et détruits en Allemagne en 2003 grâce aux procédures de la Convention de Bâle.

L'un des modèles de réussite dans ce domaine demeure le programme de contrôle de la qualité des traitements anti-acridiens (QUEST) qui prend en charge tout le cycle de vie des pesticides utilisés dans la lutte contre le péril acridien, depuis le choix du produit jusqu'à son élimination en passant par son utilisation rationnelle. Ce programme permet non seulement de réduire les niveaux d'exposition des travailleurs en milieu rural et la contamination du sol, mais également de minimiser la production de déchets dangereux (stocks de pesticides obsolètes, accumulation des contenants souillés).

c) La gestion des substances toxiques

La systématisation de l'évaluation environnementale préalable prévue par le code minier avant tout permis d'exploitation, permet de mieux prendre en compte, de façon intégrée, la gestion des substances dangereuses comme le mercure et le cyanure dans l'exploitation de l'or à l'Est du Sénégal.

Par ailleurs, des actions isolées et ponctuelles sont menées dans le domaine de la sensibilisation sur les risques liés à l'utilisation du mercure et sur les meilleures techniques et pratiques disponibles pour le secteur informel. Ces actions ciblent particulièrement la zone de Kédougou où l'exploitation artisanale de l'or est assez développée. A ce niveau, nous pouvons noter un travail de sensibilisation et de formation sur l'utilisation d'un mode de production durable dans le domaine de l'orpaillage pour éviter les intoxications liées au mercure.

2.4.2.6- Contraintes, défis et perspectives

a) Contraintes

Malgré les progrès considérables réalisés en matière de gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques, force est de constater qu'il existe encore beaucoup de difficultés dans le contrôle des substances utilisées et/ou rejetées dans l'environnement. En effet, on retrouve beaucoup de substances persistantes, bio-cumulatives et /ou toxiques dans l'environnement.

On constate des problèmes de pollution atmosphérique, marine ou terrestre. Il faut noter que le Sénégal est un pays qui utilise beaucoup d'engrais et de pesticides dans l'agriculture. Or, les dépôts de substances chimiques polluantes, les pratiques sommaires d'élimination, la mauvaise utilisation des pesticides et des engrais dégradent considérablement les sols, avec des conséquences néfastes sur la santé humaine, les ressources biologiques, les écosystèmes et les ressources en eaux.

Au Sénégal, le transport des substances dangereuses, leur stockage et leur utilisation ne sont pas totalement maîtrisés. C'est la raison pour laquelle on y enregistre des cas d'intoxication des populations et d'accidents chimiques en milieu industriel.

En outre, on peut noter que l'Administration ne dispose pas d'un personnel technique suffisant ainsi que des ressources financières devant être affectées spécifiquement à la gestion efficace des produits chimiques.

On peut relever aussi:

- la faiblesse dans l'application de la réglementation internationale et nationale ;

- la difficulté d'articuler la gestion des produits chimiques à la lutte contre la pauvreté, qui rend complexe le développement de projets économiquement viables et la mobilisation de ressources financières ;
- le déphasage entre l'ampleur de la mission de la CNGPC et la faiblesse des ressources humaines et financières dont elle dispose ;
- la forte dépendance par rapport aux ressources extérieures pour la gestion des produits chimiques et le manque d'autonomie financière de la CNGPC; la faiblesse des capacités techniques pour la veille informationnelle, le suivi et l'action ; la faiblesse de l'implication des centres d'expertise privés, notamment des laboratoires dans le contrôle des produits chimiques ;
- l'absence d'une mutualisation des ressources pour la gestion des produits chimiques, en particulier au niveau des laboratoires publics et privés ;
- l'ineffectivité d'un cadre d'harmonisation dans la gestion des produits chimiques et de suivi – évaluation compte tenu des difficultés de fonctionnement du CNGPC ;
- le faible niveau d'éducation des utilisateurs du secteur informel et du milieu rural et la pauvreté des segments sociaux ;
- la faiblesse des capacités de réaction rapide aux changements liés au commerce international des produits chimiques induits par la réglementation dans les pays développés, en particulier dans l'UE et, à la forte progression des échanges avec les Etats asiatiques émergents ;
- la difficulté d'accès et d'exploitation des données sur la gestion des produits chimiques du fait de leur format ;
- l'absence d'une nomenclature harmonisée ;

- la faiblesse de mise en réseau des bases de données existantes, d'une centralisation et d'un manque de procédures formelles dans la collecte et la diffusion des informations ;
- la faiblesse des mécanismes d'éducation et de sensibilisation sur les risques liés aux produits chimiques, en particulier dans le milieu rural et dans le secteur informel ;
- la faiblesse d'utilisation systématique par les populations d'équipements de protection individuelle ;
- la faiblesse d'une gestion écologique des emballages souillés ;
- la non –fonctionnalité des équipes QUEST locales.

b) Défis

Pour lever ces contraintes, les défis que le Sénégal se propose de relever en priorité sont déclinés ci-dessous :

- l'accélération du renforcement du cadre juridique et son application effective ;
- le renforcement d'une gestion axée sur l'analyse de cycle de vie des produits chimiques et son autofinancement ;
- le renforcement des capacités et des actions de la CNGPC ;
- le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la gestion des produits chimiques ;
- la promotion de la gestion des produits dans les stratégies de réduction de la pauvreté, les politiques industrielle, agricole et sanitaire ;
- la maîtrise et la vulgarisation de l'information en vue d'un meilleur ciblage des interventions;
- la coordination des actions au niveau stratégique et opérationnel, conformément aux engagements souscrits aux plans sous-régional, régional et international ;

- la participation des acteurs de la société civile à la sensibilisation pour l'application de la réglementation;
- la sensibilisation et une plus grande implication des centres d'expertise privés, notamment des laboratoires dans le contrôle des produits chimiques.

c) Perspectives

Dans le cadre des initiatives visant à réduire la dépendance excessive par rapport à l'utilisation de produits chimiques agricoles, le département de l'agriculture est en train de tester et d'utiliser à grande échelle une nouvelle gamme de pesticides naturels, « propre » pour l'environnement et la santé des utilisateurs et des consommateurs : il s'agit du GREEN-MUSCLE dont le principe actif est le *Metarhizium flavoviride* (5.10¹⁰ spores/gr).

Concernant les alternatives à l'utilisation des produits chimiques, le Sénégal développe une recherche/action en milieu rural assortie d'une large communication/sensibilisation/formation des utilisateurs de pesticides dans le cadre de la Gestion intégrée de la Production et des Déprédateurs (GIPD).

Un décret sur le transport de matières dangereuses basé sur les principes et lignes directrices du SGH ainsi qu'un arrêté primatorial pour l'application dudit système sont en cours d'adoption.

Notons aussi, l'existence d'un guide d'étude de danger qui permettra d'harmoniser l'évaluation des risques chimiques dans le cadre des études d'impacts sur l'environnement. Ce guide prend en compte le transport, l'utilisation et/ou le stockage des produits ou substances chimiques dangereuses.

Concernant les substances dangereuses, un projet de décret⁷ sur le plomb (dans les batteries usagées) et sur le mercure (contenu dans certains équipements) est en cours d'élaboration. Signalons aussi l'élaboration d'un texte réglementaire pour l'application obligatoire du SGH.

2.4.2.7- Etudes de cas ou pratiques de référence

- L'alerte et la surveillance éco toxicologique grâce à la mise en place d'un Centre national Anti- Poison

Le Centre Antipoison comme souligné plus haut, a pour mission d'assurer la prévention des intoxications causées, entre autres, par les médicaments, les pesticides, les produits ménagers ou industriels et les plantes, mais aussi d'améliorer leur prise en charge et de surveiller leurs effets sur la santé.

Les activités de ce centre vont de la recherche à la sensibilisation des producteurs et des utilisateurs des produits chimiques, notamment dans les domaines suivants :

- expertise pour une bonne utilisation des produits chimiques dangereux (formation des formateurs pour une bonne prise en charge des cas d'intoxication par les pesticides lors de l'aspersion intra-domiciliaire dans la lutte anti- vectorielle) ;
- étude de recherche des POPs dans le lait maternel (enquête nationale commanditée par l'OMS) ;
- prévention et sensibilisation des populations de Kédougou dans l'usage du mercure dans l'orpaillage ;
- campagnes de sensibilisation sur l'utilisation des pesticides dans les régions du Sud du Sénégal ;

⁷ Ce projet de réglementation fait suite au décès de dix huit (18) enfants contaminés par du plomb provenant d'une activité de récupération dans les batteries automobiles usagées dans la banlieue de Dakar (à Thiaroye Sur Mer)

- activités de sensibilisation, de dépistage des populations intoxiquées par le plomb à Thiaroye sur Mer;
- activités de suivi toxicologique, pharmacologique et biologique des enfants intoxiqués par le plomb et pris en charge au niveau de l'hôpital de Pikine ;
- plaider pour l'acquisition des chélateurs pour le traitement des enfants malades ;
- renforcement des capacités du personnel par des formations sur la pharmacovigilance, sur le logiciel INTOX (base de données des produits chimiques et des plantes) et sur la toxicologie en général ;
- recherche et formation (encadrement des thèses en pharmacie et mémoire) ;
- atelier de réflexion et de préparation d'un séminaire régional pour une meilleure connaissance et une meilleure prise en charge des morsures de serpents dans les pays de la CEDEAO.

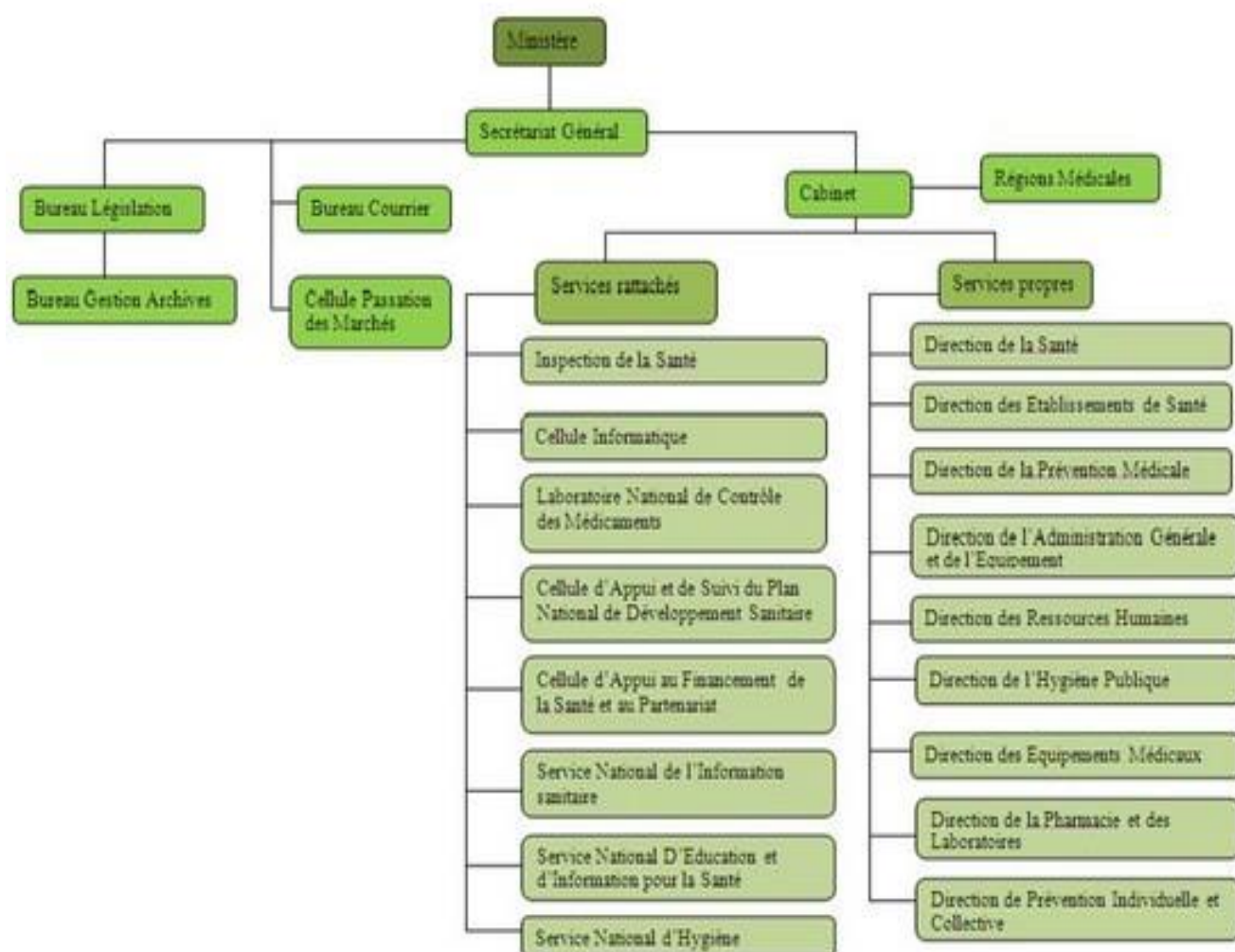
2.4.3-Les risques radiologiques

Les risques radiologiques ne sont pas négligeables au Sénégal, ce qui a motivé la création de d'une direction de la radioprotection au niveau de la primature.

2.5-Système de santé

2.5.1-Organigramme du ministère chargé de la santé

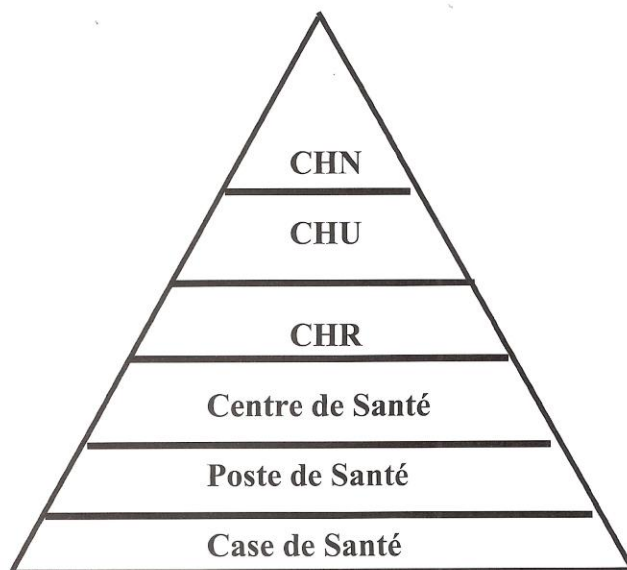
Le ministère chargé de la santé est subdivisé en directions, services nationaux et autres bureaux.



Graphique 4 : Organigramme du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Prévention, Sénégal, Novembre 2011.

2.5.2-Distribution des services de santé

Les distributions des services de santé se fait de manière pyramidale, allant de la case de santé à la base au centre hospitalier national au sommet.



Case de santé : structure de soins de santé primaires situés au sein des villages et délivrant principalement des soins promotionnels préventifs et curatifs. Elle est tenue par un ASC (Agent de Santé Communautaire).

Poste de santé : structure de santé de premier niveau sans lit situé au niveau des communes et communautés rurales offrant des soins promotionnels préventifs curatifs et de réadaptation. Il est dirigé par un Infirmier diplômé d'Etat.

Centre de santé : C'est le premier niveau où l'on trouve un médecin. On y mène des activités de soins et d'hospitalisation, des activités de maternité, de laboratoire, etc. C'est la structure de référence des postes de santé.

Hôpital régional ou CHR : Plusieurs médecins y travaillent, surtout des spécialistes : ORL, Radio, Ophtalmo., Gynéco-Obstétrique, etc. On y mène des activités de soins, d'hospitalisation, de laboratoire, etc. C'est la structure de référence des centres de santé.

CHN : C'est le domaine des spécialités les plus élevées de la pyramide sanitaire ; c'est également le lieu de formation des étudiants (Médecine, Pharmacie et Odonto- Stomatologie), du personnel en spécialisation, etc.

2.5.3-Ressources humaines⁸

Le développement des ressources humaines du secteur a nécessité l'élaboration en 1996, d'un plan national de formation du personnel de santé. Ce plan a été renforcé en 2002 par

⁸ Plan National de Développement Sanitaire en Santé 2009-2018

l'ouverture des Centres Régionaux de Formation, la création en 2003 de la Direction des Ressources Humaines (DRH) et la mise en œuvre d'une politique de contractualisation. Malgré les efforts consentis pour renforcer les effectifs, les indicateurs de couverture en personnel montrent qu'on est encore très loin des normes déjà proposées dans le PNDS 1998-2007. Cette situation découle essentiellement de trois facteurs : (i) l'insuffisance des effectifs admis au niveau des structures de formation notamment dans les Universités ; (ii) la non maîtrise du processus de recrutement dans la fonction publique qui est de la compétence du ministère en charge qui, en définitive, décide du calendrier et de la nature du personnel à recruter ; (iii) l'insuffisance des mesures incitatives pour fidéliser le personnel et réussir une meilleure répartition géographique. Le déficit en personnel est surtout important au niveau des zones difficiles et éloignées de Dakar. Une des causes est l'instabilité du personnel du fait d'un manque de motivation et d'un cadre de vie adéquat. Il s'y ajoute l'absence d'un plan de relève. Des initiatives ont été prises pour améliorer la couverture en personnel dans ces zones (indemnités d'éloignement, contractualisation des postes dans les structures situées en zones difficiles). Toutefois, elles sont restées au stade expérimental et méritent, par conséquent, d'être poursuivies et renforcées. Un effort a été fait avec l'étude sur le développement des ressources humaines de 2005 dont les recommandations tardent, toutefois, à être mises en œuvre. Le premier plan de formation qui a été élaboré dans le cadre du PNDS 1998-2007 est arrivé à terme sans que la réflexion ne soit entamée pour un nouveau plan de formation. Deux outils, en plus du plan de développement des ressources humaines, devraient être systématisés : (i) le plan de formation et (ii) la gestion informatisée du personnel.

Le tableau de synthèse ci-dessus montre que le déficit en personnel soignant par rapport aux normes du PNDS intéresse les sages femmes. En effet, les ratios personnel/population sont

passés, entre 1994 et 2008, de 1 sage femme pour 3623 FAR (Femme en Age de Reproduction) à 1 sage femme pour 3946 FAR dans le secteur public alors que pour les infirmiers, ils passent de 1 infirmier pour 4687 habitants à 1 infirmier pour 4183 habitants. Cette situation intervient dans un contexte de décentralisation de la formation des infirmiers et du renforcement des capacités des Instituts de formation du privé. Le déficit noté chez les sages femmes s'explique par l'insuffisance des effectifs formés mais également par les départs pour des raisons de retraite ou autres migrations, phénomènes jusque là non maîtrisés. Cette situation pose avec acuité la nécessité d'avoir un plan de développement des ressources humaines.

Pour les médecins, par contre, on note un progrès avec un ratio qui passe de 1 médecin pour 27833 habitants à 1 médecin pour 18615 habitants dans le secteur public. Cette progression est encore plus nette si on tient compte du secteur privé. La part importante des médecins du privé (41%) rend encore plus évidente la nécessité pour le ministère de la santé de mettre en place une politique d'intégration du secteur privé dans la mise en œuvre des programmes de santé. Dans tous les cas, la résorption du déficit en personnel et le rééquilibrage généralistes/spécialistes nécessitera une collaboration accrue entre le ministère de la santé, l'université et les écoles de formation professionnelle en santé.

Tableau I : Répartition des catégories professionnelles selon les normes, Sénégal, 2007

Catégories	Normes OMS	Normes PNDS	Couverture atteinte en 2007
Médecin	1 pour 1.000 habitants	Définies selon les types de structures	1 pour 11.000 habitants
SFE	1 pour 300 habitants	1 pour 5.000 habitants	1 pour 4.200 habitants
Infirmiers	1 pour 300 FAR	1 pour 1.500 à 2.000 FAR	1 pour 4.000 FAR

Tableau II : Répartition des catégories professionnelles selon les secteurs, Sénégal,

Année 1994 -2007

Catégories	Secteur public				Secteur privé		Effectif total	Ratio total 2008
	Année 1994		Année 2008		Effectif	Effectif		
	Effectif	Ratio	Effectif	Ratio	1994	2008		
Médecin	292	27.833	624	18.615	348	436	1.060	10.958
SFE	516	3.623	677	3.946	44	ND	ND	ND
Infirmiers	1.734	4.687	2.777	4.183	245	ND	ND	ND

2.5.4-Financement de la santé⁹

Le financement de la santé pour la période allant de l'année 2009 à 2018 est présenté dans le PNDS 2009-2018.

Le financement du PNDS 2008-2019 sera assuré par l'Etat, les Partenaires Extérieurs, les Populations et les Collectivités Locales. Il concerne les structures publiques de santé. Le secteur privé dont les flux de financement ne sont pas encore maîtrisés n'est pas pris en compte. Le volume des ressources attendues de ces différents intervenants est déterminé sur la base d'hypothèses inspirées de l'évolution constatée des financements sur les dix dernières années, des conventions de financement existantes ou des engagements multilatéraux dont l'Etat du Sénégal est partie prenante.

Ainsi, concernant les ressources attendues du budget de l'Etat, le rythme de progression du financement sera maintenu autour d'un taux moyen de 10%. Cette hypothèse se fonde sur la réalisation d'un certain niveau de performances pouvant justifier l'allocation de ressources plus importantes. Par ailleurs, il faut rappeler l'engagement de l'Etat à porter le budget de la santé à 15% conformément aux recommandations de la conférence d'Abuja.

⁹ Plan National de Développement Sanitaire en Santé 2009-2018

Le financement des Partenaires Extérieurs est estimé à partir des données prévisionnelles du PTIP (Programme Triennal d'Investissement Public) à l'horizon 2011. Il est également calculé sur la base des engagements des partenaires techniques et financiers non répertoriés dans le PTIP mais intervenant de façon constante dans le secteur de la santé. En se fondant sur les engagements pris par ces partenaires d'accompagner le Sénégal jusqu'en 2015 dans le cadre des OMD, les tendances constatées du financement extérieur pourraient se maintenir jusqu'à cette échéance et au-delà.

L'apport des collectivités locales a évolué en dents de scie au cours des dix dernières années sans jamais dépasser le seuil de 5 milliards. Dans la perspective du renforcement de leur implication, avec la mise en œuvre des POCL, on pourrait s'attendre à une augmentation significative des ressources mobilisées localement.

L'apport des populations s'est considérablement accru durant la mise en œuvre du PNDS 98-2007. Son évolution a suivi une courbe ascendante jusqu'en 2004 avec une progression moyenne de 20% par an. L'hypothèse d'une progression en moyenne de 20% par an est maintenue pour cette source de financement d'autant que la réforme envisagée au niveau des organes de gestion à la base laisse espérer que les ressources locales seront mieux tenues et gérées de manière plus transparente.

Le financement dans le secteur de la santé sera essentiellement le fait de l'Etat, des collectivités locales, des partenaires au développement et des populations. L'Etat sera le principal pourvoyeur en ressources financières du secteur de la santé dans la mise en œuvre du PNDS 2009-2018, avec un apport de **1 659.1** milliards de FCFA, représentant **64,1%** de du financement.

Il est suivi par les populations avec un apport au financement de **475.54** milliards de FCFA, représentant 19,0%. Viennent ensuite les partenaires extérieurs et les Collectivités Locales

pour respectivement **12%** et **5%** (Voir le tableau ci-dessus). Le recours à l'appui budgétaire explique la baisse relative de la part des partenaires extérieurs dans le schéma de financement du PNDS 2009-2018, une bonne partie du financement des partenaires extérieurs étant comptabilisée dans le budget de l'Etat.

L'analyse du financement en fonction de la structure économique de la dépense montre que **37,9%** des financements sont consacrés aux dépenses de fonctionnement, **37,3%** aux dépenses de personnel dont **2,7%** à la maintenance et **22,2%** aux dépenses d'investissement.

Le financement des investissements sera assuré par l'Etat à hauteur de **368,55 milliards de FCFA**, soit **65%**. Il supporte ainsi une bonne partie des investissements venant en première position dans la couverture de cette catégorie de dépense. Quant aux Partenaires Extérieurs, ils financeront **20%** des dépenses d'investissement avec un apport de **113,13 milliards de FCFA**. Les Populations et les Collectivités Locales contribueront pour respectivement **43,42** et **45,74 milliards de F CFA** soit **7,6%** et **8,01 %** des dépenses d'investissement.

Les dépenses de personnel resteront très largement à la charge de l'Etat qui y consacre **704,37 milliards de F CFA** soit un peu moins de **73 %** de l'ensemble des dépenses en personnel. On notera, cependant, le poids non moins important des Populations dans la couverture des charges de personnel avec un apport représentant **19%**. La part des Collectivités Locales et des Partenaires Extérieurs reste peu importante dans la couverture de cette catégorie de dépense.

Les dépenses de fonctionnement seront également, en majorité, à la charge de l'Etat avec un apport de **542,62 milliards de F CFA** représentant **56%** des dépenses globales de fonctionnement. Il est suivi par les Populations pour **24%**, viennent ensuite les Partenaires Extérieurs et les collectivités locales pour respectivement **19%** et **1 %**.

La répartition géographique du financement prévoit que le niveau périphérique sera légèrement prioritaire dans l'allocation des ressources avec un montant de **1 060,50 milliards de F.CFA** représentant **41,2 %** des dépenses de santé. Le niveau central venant juste après avec **37,8 %** des dépenses pour un montant alloué de **972,81 milliards de F.CFA**. Le niveau régional reçoit **21,06 %** des dépenses pour un montant de **540,57 milliards de F.CFA**. Le poids du niveau central s'explique par le fait que les hôpitaux nationaux y sont fortement concentrés.

2.6-Survol de la surveillance et réponse

2.6.1-Risques et maladies prioritaires

Les maladies prioritaires, réparties en trois (03) groupes¹⁰ sont au nombre de 39.

Liste des maladies prioritaires	
Maladies à potentiel épidémique et maladies ou évènements recommandés par le RSI	
1. Choléra 2. Dysenterie 3. Méningite (MCS) 4. Fièvres hémorragiques virales (fièvre de la vallée du Rift, Crimée-congo, Lassa) 5. Grippe humaine 6. Grippe humaine due à un nouveau sous type viral	7. Fièvre jaune 8. SRAS 9. Variole 10. Trachome 11. Chikungunya 12. Anthrax 13. Fièvre Typhoïde 14. Hépatite –B
Maladies à Eradiquer et à Eliminer	
15. Poliomyélite 16. Dracunculose 17. Lèpre	18. Tétanos néonatal 19. Rougeole 20. Noma 21. Diphtérie 22. Coqueluche

¹⁰ Guide Technique Pour la Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte, Sénégal, 2008

Autres Maladies d'Importance en Santé Publique	
23. Asthme 24. Diabète sucré 25. Épilepsie 26. Hypertension artérielle 27. Drépanocytose 28. Malnutrition 29. Diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans 30. Pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans	31. Tuberculose 32. Paludisme 33. Filarioses lymphatiques 34. Schistosomiasés 35. Onchocercose 36. Géo helminthiases (Ascaridiose, Oxyurose) 37. VIH/SIDA 38. Rage 39. Infections sexuellement transmissibles (IST)

2.6.2-Procédures de notification

Les notifications se font au niveau des structures de santé et des laboratoires. D'une manière générale et notamment pour les pathologies à potentiel épidémique, il existe une fiche spécifique de notification. Certaines maladies comme l'hypertension sont notifiées dans les rapports d'activités de routine.

La périodicité varie selon la maladie, immédiatement pour certaines comme le choléra à mensuelle pour d'autres comme la malnutrition.

2.6.3-Confirmation des événements

Pour les événements infectieux, le pays dispose de centres de référence en bactériologie, parasitologie et virologie. Une confirmation est faisable au pays, même si des études poussées comme le séquençage génétique se font parfois à l'étranger.

Ce sont les notifications des événements chimiques et radiologiques qui posent problème. Le Sénégal dispose d'un Centre AntiPoison qui est en principe le lieu d'analyse des événements chimique mais son plateau technique actuel ne s'y prête pas encore.

2.6.4-Réponse

La réponse à un événement touchant la santé se fait en palier.

La première étape se fait au niveau du ministère de la santé, sous la coordination du Comité de Gestion des Epidémies.

En cas de catastrophe avec perturbation des autres secteurs, le Plan de Contingence qui a été testé deux fois au cours de l'année 2011 pourra être mis en œuvre. Ce plan prévoit une activation du Plan d'Organisation des Secours (Plan ORSEC) qui est coordonné par le Ministère de l'Intérieur. Une articulation du Plan de Contingence National avec l'approche cluster des Nations Unies est prévue pour faciliter l'aide extérieure.

La difficulté de la riposte, conformément aux leçons apprises des épidémies passées (grippe pandémique...), se situe sur l'absence d'un fonds de riposte facilement mobilisable.

2.6.5-Activités de surveillance dans le secteur privé

Dans le secteur privé, la surveillance est encore timide, sauf en cas de découverte d'une maladie à déclaration obligatoire (fièvre jaune...).

3-OBJECTIFS DE L'EVALUATION

Les objectifs de l'évaluation sont :

- Faire les états des lieux au Sénégal de différentes capacités du RSI;
- Elaborer un plan d'action pour la mise en œuvre du RSI.

4-METHODOLOGIE

4.1-Descente sur le terrain

Une descente sur le terrain au niveau de l'aéroport international de Dakar a été réalisée par une équipe multisectorielle (ministères de la santé, de l'élevage, du transport aérien, du commerce...), appuyée par les représentants et le consultant de l'OMS.

Après une rencontre avec le Médecin chef de la police sanitaire qui a fait un exposé sur le sujet sanitaire humain, une visite du dispositif a été faite. La même méthodologie a été réalisée au niveau du contrôle sanitaire animal.

4.2-Analyse des données

Pour la revue documentaire, deux (02) ateliers ont été tenus.

Le premier a été organisé à Mbour, à 84 km de Dakar. Des représentants de quinze (15) ministères et de l'OMS ont travaillé dans un cadre résidentiel de trois (03) jours, pour faire le remplissage du guide questionnaire du RSI et initier l'analyse selon les composantes Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM).

Le deuxième a été tenu à Dakar pendant six (06) jours, avec les mêmes participants qu'à l'atelier de Mbour et qui a bénéficié du consultant dépêché par l'OMS. L'analyse FFOM a été consolidée et un draft de plan d'action a été élaboré.

Le remplissage du questionnaire a été fait en plénière pour permettre à tous de mieux le comprendre. Par la suite les analyses et le draft de plan d'action ont été réalisés dans le cadre des travaux de groupes.

4.3-Formation et rétroaction

Au cours des deux (02) ateliers relatés ci-dessus, des présentations suivies de discussions sur le RSI ont été faites, pour une mise à niveau des participants. Une version électronique du guide a été distribuée.

5-RESULTATS DE L'EVALUATION

L'évaluation s'est faite selon la méthode FFOM, complétée par les recommandations qui ont servies à l'élaboration du draft de plan d'action.

5.1-Législation Nationale, Politique et Finances

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
Existence de capacités techniques et de cadres juridique et administratif au niveau nationaux : le codex alimentarius, du code de l'hygiène (Loi N°83-71 du 05/07/1971), code de l'eau (Loi N°81-13 du 04/03/81) , code de l'environnement (Loi N°2001-01 du 15/01/2001) Et le décret d'application N°2001-282 du 12 Avril 2001 p , Loi sur les rayonnements ionisants (Loi N°2004-17 du 15/06/2004 modifié en 2009), code de la marine marchande, code de l'assainissement (Loi N°2009-24 du 08/7/2009) . Loi N°2009-14 du 02/03/2009 relative à la sécurité en matière nucléaire et à la	- Non évaluation du cadre législatif et réglementaire pour la mise en œuvre du RSI - le point focal national RSI n'a pas tous les attributs nécessaires pour une bonne conduite de sa mission			- évaluer le cadre législatif et réglementaire pour la mise en œuvre du RSI Renforcer les fonctions du Point Focal RSI - Faire un plaidoyer pour le Règlement sanitaire International à tous les niveaux / Diffusion/ Dissémination du document RSI

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
radioprotection. Décret 2004-1404 de la 14/11/2004 portant organisation du Ministère de la Santé et de la prévention ; décret n°2002/1094 du 04 nov 2002 relatif à la police sanitaire des animaux ; Arrêté n° 0059 /17 du 25 octobre 2005 portant création du système national de surveillance épidémiologique des maladies animales y compris les zoonoses Arrêté n° 10-496 du 08 décembre 2010 portant création d'un comité national de prévention et de lutte contre la rage Arrêté portant création du programme national de lutte contre les mouches tse-tse et les trypanosomiasés au Sénégal				

5.2-Coordination et Communications au Point Focal National RSI

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
Existence du plan ORSEC Nationale, du plan de contingence de la grippe (AH1N1) , du Programme National de prévention et de lutte contre les accidents chimiques et industriels, du Plan d'Intervention d'Urgence pour la grippe aviaire(qui sont des mécanismes multisectoriels et multidisciplinaires de la coordination de communication et d'intervention et de communication qui existent dans le domaine de la surveillance et de l'action en cas d'urgence et de catastrophes)	- Défaut d'un mécanisme de coordination des secteurs pertinents dans le cadre de la mise en œuvre du RSI - les obligations du PFN RSI ne sont pas communiquées aux parties prenantes concernées			- Mettre en place un cadre permanent de concertation multisectoriel RSI à partir des cadres de concertation sectoriels existants dans les domaines connexes du RSI. - Diffuser les obligations du PFN aux parties prenantes concernées

5.3-Surveillance

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
▪ Existence de comités multisectoriels de gestion des épidémies au niveau régional et départemental ▪ Existence de l'arrêté portant création du comité national de lutte contre les épidémies	▪ Mauvaise/ Faible application des dispositions de collaboration au niveau sous régional ▪ Coordination théorique au niveau régional et international ▪ Absence de procédures et de lignes directrices ▪ Mauvaise organisation du système d'information sanitaire relative à la surveillance des événements ▪ Absence d'évaluation des déclarations relatives à la surveillance des événements. ▪ Non utilisation de l'annexe 2 du RSI	▪ Existence de cadres de coopération bilatérale ou multilatérale (CEDEAO, OMVS etc.,)	▪ Risque d'introduction ou d'exportation de maladies prioritaires à partir de pays limitrophes ▪ Incohérence dans l'approche de la surveillance des événements de santé	▪ Renforcer la coordination de la surveillance au niveau national et sous régional ▪ Améliorer le système de surveillance des événements ▪ Promouvoir l'utilisation de l'annexe 2 du RSI par les acteurs concernés

5.4-Réponse

FORCES	FAIBLESSES	RECOMMANDATIONS
▪ Mise en place d'un centre opérationnel spécial ▪ Existence de lignes directrices sur la PEC des affections prioritaires ▪ Existence d'une politique nationale de prévention et de lutte contre les infections ▪ Existence de RH qualifiées dans la prévention et la lutte contre les infections ▪ Mise en œuvre de plans de lutte contre les infections au plan national	▪ Insuffisance de ressources permettant une action rapide ▪ Absence de procédures ???? ▪ Absence d'évaluation de procédures ??? ▪ Absence d'équipes d'intervention rapide ▪ Absence de procédures opératoires standardisées au déploiement de l'équipe d'intervention rapide ▪ Absence d'évaluation de l'action ▪ Impossibilité d'agir dans les délais requis de 48 h ▪ Absence d'accord d'assistance mutuelle en cas de crises ▪ Inexistence de la surveillance au niveau des structures hospitalières ▪ Absence de procédure pour la PEC des patients nécessitant des mesures d'isolement	Mettre en place des fonds destinés à la gestion des urgences sanitaires 1- Plaider pour une disponibilité des ressources nécessaires à la gestion des urgences sanitaires ▪ (Elaborer et diffuser des procédures standardisées de gestion des urgences sanitaires ▪ Assurer la documentation sur la gestion des urgences sanitaires ▪ Appliquer les procédures de décontamination en cas d'urgences sanitaires ▪ appliquer les procédures d'orientation et de transport des patients en cas d'urgences sanitaires) 2- Créer un environnement favorable à des interventions efficaces et traçables ▪ Mettre en place aux différents niveaux du système des équipes multidisciplinaires d'intervention sanitaire rapide 3-Décentraliser les interventions rapides en cas d'urgences sanitaires

FORCES	FAIBLESSES	RECOMMANDATIONS
	spécifiques ▪ Absence de surveillance des groupes à risque ▪ Absence d'un programme national de protection des agents de santé	4-Promouvoir une politique d'assistance et d'aide entre les Etats (Signer des accords d'assistance mutuelle avec les voisins)

5.5-Préparation

FORCES	FAIBLESSES	RECOMMANDATIONS
▪ Existence d'un plan d'action d'urgence en santé publique englobant les risques relevant du RSI et des points d'entrée ▪ Mise en place de procédures, plans ou stratégies de collecte de ressources pour soutenir les activités au niveau communautaire/primaire d'action ▪ Existence d'un plan de gestion et de distribution des stocks nationaux	▪ Inexistence d'un système d'évaluation des capacités pour l'application du RSI ▪ Absence de test et ou d'exercice de simulation de certains plans ▪ Absence de mise à niveau des agents de santé pour faire face aux urgences en santé publique ▪ Absence de documentation concernant l'action d'urgence ▪ Absence de liste d'experts	▪ Mise en place d'un système d'évaluation et de renforcement de capacités ▪ Elaborer et rendre disponible une liste des experts pour faire face aux urgences sanitaires ▪ Intégrer dans la liste des médicaments essentiels des produits pour la PEC des urgences chimiques et radiologiques

FORCES	FAIBLESSES	RECOMMANDATIONS
	pour faire face au risque dans le cadre du RSI ▪ Absence d'évaluation des risques au niveau national permettant de déterminer les événements de santé publique urgents ▪ Non prise en compte des produits chimiques et radiologiques dans les stocks essentiels ▪ Non contribution du pays dans les stocks internationaux	1-Créer les conditions favorables à une bonne application du RSI et un renforcement des compétences des acteurs ▪ Tester périodiquement tous les plans disponibles ▪ Faire une évaluation des risques au niveau national 2- Assurer une mise à jour des plans, manuels et procédures pour une bonne PEC des urgences sanitaires ▪ Documenter toutes les actions d'urgence au plan national 3-Assurer une traçabilité des interventions d'urgence sanitaire ▪ Pré positionner en permanence au niveau de toutes les PRA des stocks de sécurité de médicaments et produits médico-pharmaceutiques pour la gestion des urgences sanitaires 4- Créer les conditions d'évaluation et les modalités d'utilisation des

FORCES	FAIBLESSES	RECOMMANDATIONS
		stocks nationaux

5.6-Communication de risque

FORCES	FAIBLESSES	RECOMMANDATIONS
▪ Accessibilité des média et du public aux sources d'information ▪	▪ Absence de guide, manuels de procédures opératoires et de Plan de communication des risques. ▪ Non identification des partenaires et parties prenantes dans le domaine de la communication de risque ▪ Inexistence d'un plan de communication et de procédures opératoires standardisées en matière de risque ▪ Insuffisance du matériel d'information, d'éducation et de communication adaptés aux besoins de la population ▪ Impossibilité de respecter le délai de 24 h dans la diffusion de l'information en cas d'urgence	▪ Identifier les partenaires et parties prenantes dans le domaine de la communication de risque ▪ Elaborer des plans de communication et des procédures opératoires standardisées en matière de risque ▪ Mettre en place une unité de coordination de la communication 1-Promouvoir une politique intégrée de communication de risque

FORCES	FAIBLESSES	RECOMMANDATIONS
	de santé publique Absence de système d'évaluation de la communication	- Mener périodiquement des exercices de simulation - Mettre en place un système d'évaluation et de publication des résultats des interventions - Mettre en place des conditions favorisant le respect des délais prescrits 2-Créer les conditions favorables à un respect des délais, une mise à jour et un suivi du plan de communication en urgence sanitaire

5.7-Ressources humaines

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
existence d'un plan national de développement des ressources humaines au niveau du MSHP	- Difficulté dans la mise en œuvre adéquate du PNDRH du MSHP - Absence de Plan de développement des RH			développer les capacités des Ressources Humaines en RSI en y incluant les ministères concernés

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
	pour la mise en œuvre du RSI			■

5.8-Laboratoires

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
▪ Existence d'un Réseau National de laboratoires fonctionnel et de laboratoires de référence en cas de menace sanitaire prioritaire ▪ Inventaire des capacités des laboratoires ▪ Existence de programme d'évaluation externe de la qualité ▪ Cadre légal, réglementaire et normatif existant ▪ <i>Lignes directrices existant</i>	▪ Absence de cartographie des laboratoires pour la détection des événements infectieux, chimiques et liés à la sécurité sanitaire des aliments ? ▪ Implémentation des lignes directrices en matière de biosécurité et de bio sûreté non structurée ▪ Insuffisance d'une réglementation relative à la protection et à la sécurité des personnels ▪ Insuffisance de l'apport des laboratoires hospitaliers dans la surveillance épidémiologique			▪ Renforcer la sécurité et la sureté des laboratoires ▪ Renforcer l'organisation structurelle et fonctionnelle des laboratoires ▪ ...Aspects assurance qualité ???.....

5.9-Événements zoonotiques

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
▪ Possibilité d'accéder aux services des laboratoires nationaux et internationaux, pour confirmer l'existence d'événements prioritaires (aspects diagnostics et entomologiques) ▪ Existence de Capacité de prise en charge des événements liés aux zoonoses pouvant avoir une portée nationale ou internationale (à 80%) ▪ Communication régulière des risques et événements liés aux zoonoses à la communauté internationale	▪ Inexistence de coordination entre autorités publiques responsables et le point focal national RSI pour la détection et la riposte par rapport aux événements liés des zoonoses ▪ Insuffisance de la politique de santé pour la surveillance et la gestion des zoonoses ▪ Inexistence d'un répertoire des experts mobilisables au plan national pour faire face à des événements liés aux zoonoses	▪ utilisation du système d'information concernant les zoonoses au plan mondial ▪ Existence d'un réseau d'experts disponibles et d'un réseau de laboratoires au plan international	▪ Le non notification des cas de zoonoses chez les pays voisins et le manque d'échanges d'informations	▪ mettre en place d'un système de coordination entre les secteurs de la santé humaine et animale pour la prévention et la riposte face aux événements liés aux zoonoses ▪ Elaborer et actualiser les plans d'urgence opérationnels et intersectoriels en cas d'événement d'origine zoonotique. ▪ Établir et actualiser régulièrement la liste d'experts capables d'agir en cas d'événement d'origine zoonotique

5.10-Sécurité Sanitaire Alimentaire

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
▪ Existence de normes nationales et internationales en matière de sécurité sanitaire des aliments ▪ Adhésion du Sénégal au réseau INFOSAN ▪ Existence de réglementations et de politiques nationales visant à assurer le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments ▪ Existence d'un mécanisme de coordination et de collaboration multisectoriel ▪ Existence de services d'inspection chargés de contrôler les risques d'origines alimentaires (Commerce ; Hygiène, élevage et DPV) ▪ Accès à des services de laboratoires pour la confirmation d'événements prioritaires de portée nationale et internationale ▪ Existence de mécanismes de recherche, de rappel et d'élimination des produits contaminés ▪ Mise en œuvre de systèmes de gestion et de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments	▪ Inexistence de mécanismes opérationnels de coordination entre les autorités responsables de la SSA et le point focal national RSI ▪ Inexistence de liste des risques prioritaires et d'experts ▪ Inexistence de lignes directrices ou de manuels relatifs à la surveillance, à l'évaluation et à la gestion des événements prioritaires ▪ Absence de gestion des données épidémiologiques en matière de contamination des produits alimentaires ▪ Inexistence de plans d'urgence opérationnels non testés	▪ Adoption des normes internationales (OIE ; Codex alimentarius ; CIPV)		▪ Mettre en place d'une structure de coordination de la SSA (cellule de veille, d'alerte et riposte) ▪ Mettre en place un portail national pour la SSA ??? ▪ Etablir de listes d'expert et des risques prioritaires ▪ Systématiser l'analyse des risques ???? / Evaluer les risques prioritaires ???...

5.11-Événements chimiques

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
▪ Recensement de spécialistes capables d'évaluer la situation en matière de santé publique et de faire face à des incidents chimiques ▪ Principaux sites et installations présentant un danger chimique, répertoriés ▪ Disponibilité et accès aux services de laboratoire aux fins de confirmation des événements chimiques prioritaires ▪ Existence d'un centre antipoison ▪ Rapportage au niveau international de l'expérience	▪ Absence de point focal et de mécanismes pour la coordination et la communication en cas d'événement chimique ▪ absence de plans d'urgence préétablis aux fins de surveillance, d'alerte et d'action en cas de survenue d'incident chimique ▪ Absence de liste d'événements / de syndromes chimiques prioritaires ▪ Non disponibilité de manuels et de procédures opératoires standardisées	▪ Efficacité dans la gestion des risques chimiques ▪ Partage d'informations avec la communauté internationale ▪ Possibilité d'établir une cartographie des zones à risques		▪ <i>Elaboration d'une politique de gestion des risques chimiques ?????!!</i> ▪ Mise en place de mécanismes de coordination entre les différents secteurs ▪ Elaboration et diffusion de manuels et de procédures opératoires standardisées

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
acquise et des constatations faites concernant les risques chimiques de portée nationale et internationale				

5.12-Urgences radionucléaires

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
▪ Existence de l'Autorité de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire (ARSN) ▪ Existence d'une législation sur la radioprotection et la sûreté nucléaire.	▪ Inexistence d'un mécanisme de surveillance des événements radiologiques? ▪ Inexistence de structures de prise en charge des situations d'urgence radiologiques et nucléaires ▪ Inexistence de mécanismes pour faire face aux situations d'urgences radiologiques	▪ Coopération avec l'Agence internationale de l'Energie Atomique (AIEA). Ratification sous l'égide de l'AIEA de la Convention Internationale sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique ainsi que de la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire.		▪ Mettre en place un mécanisme de surveillance des événements radiologiques. ▪ Recensement de toutes les pratiques et sources de rayonnement associées à ces pratiques. ▪ Etablir un plan national d'urgence radiologique dans le cadre du plan ORSEC national. ▪ Mise en place au sein de l'ARSN de la structure chargée de la prise en charge des situations d'urgence radiologique. ▪ Etablir les mécanismes de prise en charge des situations d'urgence radiologique.

5.13-Points d'entrée

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
▪ Existence d'une réglementation de contrôle sanitaire aux frontières ▪ Inspections sanitaires aux portes d'entrée (port et aéroport) ▪ Existence de Haute Autorité pour le Ports et pour l'Aéroport	▪ Absence de désignation officielle des points d'entrée ▪ Absence d'actualisation du cadre réglementaire et du système documentaire ▪ Absence d'évaluation des points d'entrée ▪ Absence d'harmonisation des points d'entrée avec les pays limitrophes ▪ Insuffisance des ressources nécessaires pour le contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée ▪ Non utilisation des documents sanitaires à certains points d'entrée ▪ Défaut de coordination et de communication entre les établissements médicaux et les points d'entrée ▪ Absence de système d'évaluation de la surveillance pour les menaces prioritaires ▪ Absence de procédures standardisées et de plans pour les interventions d'urgence et	▪ Existence de cadres organisationnels (Asecna, OACI, OMAOC, OMI, Etc)	▪ Instabilité politique de certains pays ???	▪ Evaluation des capacités des points d'entrée ??? ▪ <i>Renforcer les capacités au niveau des points d'entrée</i> ▪ Améliorer la gestion des urgences de santé publiques au niveau des points d'entrée ▪ Coordination, lutte antivectorielle ???

FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES	RECOMMANDATIONS
	le contrôle de routine			

5-RECOMMANDATIONS

6-PERSPECTIVES

Les perspectives immédiates sont :

- La mise en place d'un Comité Multisectoriel de Mis en Œuvre du RSI composé des points focaux des différents ministères impliqués et partenaires;
- Désignation officielle des points d'entrée qui doivent acquérir et maintenir les capacités requises du RSI;
- Conduire l'évaluation des capacités au niveau des points d'entrée désignés.

7-ANNEXES

8-PLAN D'ACTION

LEGISLATION

But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
				2012	2013	2014			
Mettre en place un cadre réglementaire favorable à la mise en œuvre du RSI	Disposer d'un cadre juridique suffisant pour satisfaire aux obligations du RSI d'ici fin 2014	L'ensemble des textes législatifs, réglementaires et prescriptions administratives pertinents sont collectés, exploités et au besoin révisés	tenir une réunion préparatoire de la revue documentaire	X			MSHPP(CTAJ-IAAF) et les Chargés des affaires juridiques et/ ou de la réglementation des autres secteurs impliqués dans le RSI.		réunion tenue
			Recenser et analyser les textes législatif, réglementaires et prescription administrative pertinentes pour la mise en œuvre du RSI (Consultation ou groupe technique)	x			MSHPP(CTAJ-IAAF) et les Chargés des affaires juridiques et/ ou de la réglementation des autres secteurs impliqués dans le RSI.	5 945 400	Répertoire des textes législatifs et réglementaires disponible

			organiser un atelier d'analyse des textes législatifs, réglementaires et prescriptions administratives pertinents et de propositions de dispositions complémentaires pour la mise en œuvre du RSI	X			MSHPP(CTAJ-IAAF) et les Chargés des affaires juridiques et/ ou de la réglementation des autres secteurs impliqués dans le RSI.	5 998 200	Textes législatifs et réglementaires complémentaires pour la mise en œuvre du RSI identifiés
			organiser un atelier de validation des textes avec les PTF et les partenaires sociaux	X			MSHPP(CTAJ-IAAF) et les Chargés des affaires juridiques et/ ou de la réglementation des autres secteurs impliqués dans le RSI.	5 998 200	Textes complémentaire à la mise en place du RSI élaborés et validés
	Assurer une meilleure connaissance du RSI	Le point focal RSI est connu à tous les niveaux	Prendre un acte réglementaire précisant davantage les attributions du Point Focal National RSI et le diffuser auprès de tous les secteurs impliqués	X			MSHPP: CTAJ		acte réglementaire pris et diffusé

		Un comité multisectoriel RSI est mis en place	Elaborer un arrêté ministériel mettant en place un comité multisectoriel RSI impliquant tous les secteurs pertinents et le diffuser	X			MSHPP: CTAJ		acte réglementaire pris et diffusé
		strategie de plaidoyer elaboree	organiser des sessions de formation des acteurs de mise en œuvre du RSI au niveau intermédiaire et opérationnel (membres des CRD et CDD) Nbre de sessions? Durée? Nbre de pers?	X	X	X	PFN RSI	???	Nombre de personnes formées
			Organiser des journées de sensibilisation des Parlementaires Partenaires sociaux, et Partenaires techniques et financiers Nbre de sessions? Durée? Nbre de pers?	X	X	X	PFN RSI	???	Nombre de personnes sensibilisées
			Reproduire en X exemplaires et diffuser le RSI 2005	X	X	X	PFN RSI	???	Nombre d'exemplaires distribuées

			Sous total 1						
Coordination									
But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
				2012	2013	2014			
Mettre en place un cadre permanent de concertation multisectoriel RSI à partir des cadres de concertation sectoriels existants dans les domaines connexes du RSI	Améliorer la coordination intra et intersectorielle entre acteurs impliqués dans la mise en œuvre du RSI d'ici fin 2014	Des réunions trimestrielles d'harmonisation et de coordination du comité multisectoriel RSI sont tenues	Organiser des réunions trimestrielles d'harmonisation et de coordination du comité multisectoriel RSI	X	X	X	MSHPP : PFN RSI	A budgetiser	Nombre de réunions tenu/nombre prévu
			Mettre en place une unité multisectorielle chargée du développement des capacités des Ressources humaines des secteurs pertinents dans le domaine du RSI	X			PFN RSI		Unité fonctionnelle
			Désigner un Point Focal chargé du RSI au niveau de chaque secteur pertinent et diffuser son contact auprès du Point Focal national RSI	X			MSHPP: PFN RSI		PF désignés officiellement pour chaque secteur
			Sous total 2						

SURVEILLANCE									
But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
Améliorer le système de surveillance des urgences de santé publique	Améliorer la coopération sous-régionale en matière de surveillance	La coopération sous régionale en matière de surveillance est améliorée		2012	2013	2014			
			Recenser les textes disponibles régissant la coopération en matière de santé avec les pays limitrophes	Janvier			MSHPP	PM	Répertoire des textes disponible
	Améliorer le système de recueil et de traitement de l'information pour le système de surveillance des événements	Amélioration du système de recueil et de traitement de l'information liée à la surveillance des urgences de santé publique	Tenir au moins une fois par an des rencontres avec les responsables de la surveillance épidémiologique des pays limitrophes	x?	Janvier		MSHPP	8 526 000	Nombre de rencontres organisées et procès verbaux
			Tenir un atelier d'identification des urgences de santé publique de portée internationale et d'élaboration des fiches de notification	Juillet			MSPHP	10 160 500	Les urgences prioritaires sont définies et les fiches de notification disponibles
			Reproduire et diffuser les fiches de surveillance des événements chimiques, ionisants et pour les infections/affections ne disposant pas de fiches .	Juillet			MSPHP	500 000	Rupture de stock en fiches au niveau des structures sanitaires

			Identifier au niveau du Ministère de la Santé une unité en charge de la surveillance des évènements chimiques, ionisants et des infections/affections ne faisant pas partie de la surveillance intégrée des maladies	Février			MSHPP	PM	Unité clairementt identifiée et fonctionnelle
			Diiffuser l'annexe 2 du RSI à tous les médecins	Avril				PM	
			Organiser une supervision semestrielle de la surveillance y compris celle de l'utilisation de l'annexe 2 du RSI	Octobr e				12 472 460	Nombre de supervisions organisées
			Sous total 3						

REPONSE – ACTION

But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
Améliorer les capacités pour une réponse rapide face aux épidémies et autres événements de santé publique	1- Améliorer la Prise en charge des victimes en cas d'urgence de santé publique			2012	2013	2014			

	Une prise en charge appropriée des victimes est assurée	1-1-Organiser un atelier de sensibilisation et d'information sur la mobilisation des ressources en faveur du RSI à l'endroit des décideurs(parlementaires , ministères concernés et collectivités locales)	x			MSHPP et Partenaires	5 439 000	Lignes budgétaires RSI inscrites
		Contractualiser avec un cabinet pour l'élaboration des normes et procédures opérationnelles standards en urgence de santé publique	x			MSHPP et Partenaires	7 500 000	Manuels de normes et procédures élaborées et validées. Nbre d'exemplaires distribués
		1-2 Organiser pendant 3 jours un atelier de validation des procédures opérationnelles standards (organisation des secours, transport et PEC des victimes et évaluation des interventions)	x			MSHPP	8 323 000	Procédures opératoires et directives élaborées et validées
		Organiser des sessions de vulgarisation des normes et protocoles d'un jour par axe ciblant des pools d'acteurs régionaux de la réponse	x			MSHPP	10 901 500	Nombre de personnes formées

	Renforcer la coopération et le partenariat avec les pays voisins en cas d'urgence de santé publique	Collaboration avec les pays voisins en cas d'urgence de santé publique effective	1-3-Prendre par un acte officiel définissant la composition, la mise en place et les ressources des équipes d'intervention rapide aux différents niveaux du système.	x			MSHPP	PM	Equipes d'interventionnelles opérationnelles aux différents niveaux
			2-1-Etablir des accords de partenariat avec les pays voisins pour une synergie d'intervention face aux urgences de santé publique	x	x		MSHPP	PM	Accords de partenariat signés
			2-2-Intégrer dans les cadres de coopération existants (commissions mixtes établies, OOAS, coopération transfrontalière...) la réponse conjointe en cas d'urgence de santé publique	x	x		MSHPP	PM	La réponse en cas d'urgence inscrite dans les cadres de coopération
			Sous total 4						

PREPARATION

But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
				2012	2013	2014			

Améliorer les capacités nationales de riposte aux urgences sanitaires 1- Améliorer l'efficacité des stratégies et outils d'intervention Les interventions efficaces sont réalisées dans les délais requis	1-1-Organiser des réunions annuelles de suivi de la mise en œuvre du plan d'action	x	x	x	MSHPP	1 190 000	Proportion d'interventions réalisées conformément aux normes et protocoles
	1-2- Organiser tous les deux ans des exercices de simulation pour tester l'opérationnalité des plans d'urgence en y associant au besoin les pays voisins.		x		MSHPP	18 347 500	
	1-3-Contractualiser avec un cabinet pour la mise à jour de la carte sanitaire					7 500 000	
	1-4-Organiser un atelier de validation de deux jours de la carte sanitaire et actualiser la liste des médicaments essentiels					6 422 000	
	Sous total 5					33 459 500	

COMMUNICATION DES RISQUES

But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
				2012	2013	2014			

Assurer une bonne politique de communication en matière d'urgence de santé publique	1-Assurer une disponibilité et une accessibilité de l'information en situation d'urgence de santé publique	L'information en situation d'urgence sanitaire est disponible et accessible	1-1-Organiser pendant 3jours un atelier multisectoriel d'élaboration d'un plan de communication en matière d'urgence de santé publique	x			MSHPP	4 845 900	Plan de communication en matière d'urgence de santé publique élaboré
			1-2-Organiser en un jour un atelier de validation et de diffusion du plan de communication	X			MSHPP	3 641 000	Plan de communication en matière d'urgence de santé publique validé et diffusé
			1-3-Organiser en trois jours un atelier de réalisation des supports de communication	X			MSHPP	4 845 900	Supports de communication élaborés
			1-4-Organiser par axe des sessions de vulgarisation des supports de communication auprès des acteurs	X			MSHPP	10 901 500	Nombre d'acteurs formés
			Sous total 6						

Ressources humaines

But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
Développer	Disposer	Les		2012	2013	2014			

les capacités en ressources humaines dans le cadre de la mise en œuvre du RSI	dune expertise adaptée pour la mise en œuvre du RSI	ressources humaines sont formées pour la mise en œuvre du RSI et la liste des experts dans chaque domaine est diffusée	organiser un atelier de formation des points focaux des secteurs concernés dans la mise en œuvre du RSI	X	X	X	MSHPP: PFN RSI	5 998 200	nombre de PF de secteurs formés/nombre prévu
			Etablir et diffuser la liste des experts dans chaque domaine (capacités principales)	X			MSHPP: PFN RSI	500 000	Liste des experts diffusée
			Faire l'inventaire des besoins en formation dans le cadre du RSI (Consultation ou groupe technique)	X				5 945 400	Un rapport sur la situation et les besoins disponibles
			Organiser un atelier d'élaboration d'un plan de développement des RH dans le cadre de la mise en œuvre du RSI	X				5 998 200	Plan de développement des RH validé et adopté
			Sous total 7					18 441 800	

LABORATOIRES

But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
				2012	2013	2014			
Améliorer les capacités des laboratoires pour la confirmation en toute sécurité des urgences de santé publique	Améliorer la coordination des réseaux de laboratoires	collaboration entre laboratoire renforcée	Mettre en place un cadre de coordination et concertation entre le RNL et les autres laboratoires chargés de la surveillance des événements chimiques, zoonotiques et sécurité sanitaire des aliments.					Budget	Procédures de collaboration formalisées

de portée internationale	Faciliter l'accès aux laboratoires pour la confirmatio ns des urgences de santé publique	Le référencement des laboratoires capable de confirmer les urgences de santé publique est amélioré.	Confectionner un annuaire des laboratoires habilités à la gestion des urgences de santé publique ainsi que de leur domaines d'expertise.	Juillet			Multisectoriel	177 500	Annuaire disponible
			Participation des laboratoires de référence à des programmes internationaux d'évaluation externe de la qualité (frais abonnement)	X	X	X		Budget	Nombre de contrôles de la qualité
	Améliorer les capacités des laboratoires	La capacité des laboratoires pour la gestion des urgences de santé publique est améliorée.	Organiser un programme d'évaluation externe de la qualité pour les laboratoires régionaux	X	X	X		Budget	Nombre de participations au contrôle de la qualité
			Evaluer les capacités des laboratoires implliqués dans la surveillance des événements (zoonotique, sécurité sanitaire des aliments et chimique)	X				Budget	
			Tenir une réunion d'élaboration d'une démarche de certification pour les laboratoires habilités à confirmer les urgences de santé publique de portée internationale	Juillet			Multisectoriel	PM	

	Assurer une bonne sécurité des travailleurs de laboratoire et de l'environnement	La sécurité des travailleurs de laboratoires et de l'environnement est améliorée	Tenir une réunion d'élaboration d'un plan de mise aux normes des laboratoires habilités à la confirmation des urgences de santé publique de portée internationale		Janvier		Multisectoriel	PM	
			Former les responsables de laboratoire en biosécurité et en biosureté	Juillet			Multisectoriel	6 729 200	
			Identifier des points focaux (Référénts) pour chaque région en charge de la planification et de l'évaluation de la biosécurité et de la biosureté dans les laboratoires	AOUT			Multisectoriel	PM	
			Sous total 8						

POINTS D'ENTREE

But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
Réduire le	Améliorer	Le contrôle		2012	2013	2014			

risque de propagation des urgences de santé publique au niveau des points d'entrée	les conditions de contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée	sanitaire est améliorée au niveau des points d'entrée	Elaborer un plan de développement des ressources nécessaires au contrôle sanitaire pour les urgences de santé publique de portée internationale				Multisectoriel		Plan élaboré et validé
			Elaborer et partager les procédures opératoires pour la gestion des urgences de santé publique au niveau des points d'entrée.	Décembre			Multisectoriel		Manuel de procédures élaborés et validé
	Mettre à jour le cadre réglementaire et le système documentaire	Le cadre réglementaire et le système documentaire est actualisé	Harmoniser les points d'entrée au niveau des frontières en concertation avec les pays limitrophes		Janvier		M Intérieur		Les points d'entrée transfrontaliers identifiés avec les pays limitrophes
			Notifier officiellement les points d'entrée choisis à l'OMS (5 parmi 11): Port de Dakar, aeroports LSS et AIBD, Rosso et Kidira		Février		Point focal RSI	PM	Les points d'entrée retenus pour le RSI sont officiellement notifiés à l'OMS
	Améliorer la communication entre les acteurs externes, les établissements de santé et les points d'entrée	La communication est améliorée entre les points d'entrée, les établissements de santé et les acteurs externes	Réviser le cadre réglementaire actuel et le système documentaire (Procédures opératoires) afin de faciliter la mise en œuvre du RSI au niveau des points d'entrée désignés	Déc			Multisectoriel	PM	
			Elaborer un tableau de bord pour le suivi et l'évaluation du contrôle sanitaire des urgences de santé publique de portée internationale au niveau des points d'entrée	Juillet			Multisectoriel	0	Rapports d'évaluation et réunions de restitution

			Elaborer un plan de communication entre les points d'entrée, les établissements de santé et les acteurs externes	Juillet			Multisectoriel	PM	Plan élaboré et validé
	Renforcer les capacités requises RSI au niveau des points d'entrée	Les principales lacunes sont identifiées et un plan de renforcement des capacités élaboré	Mener une évaluation des capacités requises au niveau des points d'entrée désignés pour le RSI	Janvier					Rapport sur l'analyse situationnelle disponible
			Organiser un atelier de validation de l'analyse situationnelle et élaboration de renforcement des capacités	Février					Plan de renforcement des capacités des points d'entrée élaboré et validé
			Plaidoyer et mobilisation des ressources pour le plan de renforcement des capacités au niveau des points d'entrée						Ressources disponibles
			Sous total 9						

EVENEMENTS LIES A DES ZONROSES

But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
				2012	2013	2014			
Améliorer la prise en charge des risques liés aux	Renforcer la coordination entre les différentes parties	la coordination entre les différentes parties prenantes y	Désignation d'un point focal de la santé animale	x			Min. Elevage	x	point focal designé

zoonoses	prenantes y compris les laboratoires concernés pour la gestion des événements liés aux zoonoses		compris les laboratoires concernés pour la gestion des événements liés aux zoonoses est renforcée	Mettre en place un comité technique pluridisciplinaire	x			PFN RSI	500000	comité technique opérationnel
	Renforcer les échanges d'informations et de bonnes pratiques entre les laboratoires impliqués dans la gestion des événements liés aux zoonoses	les échanges d'informations et de bonnes pratiques entre les laboratoires impliqués dans la gestion des événements liés aux zoonoses sont établis	Organiser un atelier d'élaboration et de validation des normes et procédures dans le cadre de la gestion multisectorielle des événements zoonotiques	X			Point Focal Elevage - PFN RSI	Budget	Normes et procédures en situation d'urgences élaborées et validées	
			Mettre en place les procédures d'Echange régulier d'information entre les laboratoires santé humaine et santé animale	x	x	x	Point focal Elevage	Budget	collaboration efficace entre les laboratoires santé humaine et animale	
			Etablissement d'un répertoire d'experts mobilisables	x			comité technique	800000	répertoire d'experts établi	
			Etablissement d'une base de données épidémiologique des maladies zoonotiques	x			comité technique	2 000 000	base de données épidémiologiques établie et régulièrement mise à jour	
			Mise en place d'un réseau de laboratoires impliqué dans la gestion des maladies zoonotiques	x			comité technique	Atelier de 30 pers. 1 632 000 F	réseau de laboratoires mis en place et fonctionnel	
	Sous total 10									

SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
				2012	2013	2014			
Garantir aux consommateurs des denrées alimentaires salubres	Mettre en place un dispositif de coordination entre les acteurs de la sécurité sanitaire des aliments	un dispositif de coordination entre les acteurs de la sécurité sanitaire des aliments est mis en place	Redynamiser la commission de contrôle des produits alimentaires et l'affiliée au Codex	x	x	x	M. Commerce et MSHPP	3 réunions par an 4 500 000 F	la commission de contrôle des produits alimentaires opérationnelle (Nbre de réunions et PV)
			Rnforcer le point focal Codex	x			MSHPP	2 Ordinateurs une imprimante et une photocopieuse 1 850 000 f	la coordination du codex renforcée et fonctionnelle
			Impliquer davantage le Sénégal au réseau INFOSAN	x	x	x	points focaux Santé, Commerce, Elevage et Agriculture	x	le Sénégal membre actif du réseau INFOSAN
			Organiser des réunions de coordination entre le PFN RSI et les parties prenantes	x	x	x	PNF RSI	3 réunions par an 4 500 000 F	une bonne coordination entre le PFN RSI et les autres secteurs
	Maitriser les risques sanitaires liés aux aliments	les risques sanitaires liés aux aliments sont maitrisés	Elaborer et tester des plans de gestion des situations d'urgence liées à la sécurité sanitaire des aliments	x	x	x	commission de contrôle des produits alimentaires	2 ateliers: 3 264 000F et 2 tests: 24 000 000F à raison de 12 000 000 F par test	des plans d'urgence opérationnels sont disponibles
			Etablir la liste des risques alimentaires	x			commission de contrôle des produits alimentaires (section de l'information)	Atelier de 30 pers. 1 632 000 F	la liste des risques alimentaires identifiés est disponible

			Renforcer les services d'inspections et de contrôle pour la maîtrise de la SSA (mise à la norme ISO 17020)	x	x	x	MSHPP (SNH) - M. Commerce - Min. Elevage	6 vehicules à raison de 2 par secteur : 6x14 000 000 = 84 000 000 F	les services d'inspections et de contrôle sont renforcés
			Evaluer les capacités des laboratoires de contrôle de la qualité des aliments (se référer à la composante LABORATOIRES)	x	x		PM	PM	les laboratoires mis aux normes (ISO 17025)
			Organiser des ateliers de formations dans le cadre de l'analyse des risques	x			??????	3 ateliers: 4 896 000 F à raison de 1 632 000 F par atelier	nombre de formations réalisées dans le cadre de l'analyse des risques
			Equiper en matériels informatiques l'organisme national de normalisation	x				2 Ordinateurs une imprimante et une photocopieuse 1 850 000 f	l'organisme national de normalisation renforcé en moyens techniques
			Organiser 2 ateliers de formations sur la maîtrise de la SSA (mise en place de BP d'hygiène, HACCP, Iso 22000) à l'intention des entreprises	x	x			2 ateliers: 3 264 000F	nombre d'entreprises formées et nombre d'ateliers de formations réalisés dans le cadre de la SSA
			Sous total 11						

EVENEMENTS CHIMIQUES

But	Objectifs	Résultats attendus							
Améliorer la prise en charge des			Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
				2012	2013	2014			

incidents liés aux evenements chimiques	Mettre en place une cellule de coordinati on entre les différents secteurs	une cellule de coordination entre les différents secteurs opérationnelle	désigner un point focal pour coordonner avec le PFN RSI	x			Centre Anti-Poison (CAP)	x	un point focal désigné
			établir la liste des experts et services concernés	x			Min. Environnement (DEEC)	Atelier de 30 pers. 1 632 000 F	une liste des experts et services concernés établie
	Mettre en place un système de surveillanc e des incidents chimiques	un système de surveillance des incidents chimiques est mis en place	Elaborer et diffuser des procedures et manuels de prise en charge des incidents chimiques	x	x		Centre Anti-Poison (CAP)	2 ateliers de 30 pers. 3 264 000 F et 1 200 000 F la diffusion	des procedures et manuels élaborés et diffusés
			établir une cartographie des zones à risques	x			Min. Environnement (DEEC)	Atelier de 30 pers. 1 632 000 F	une cartographie des zones à risques etablie
			Elaborer et tester un plan multisectorie d'intervention d'urgence liée aux événements chimiques	x			Min. Environnement (DEEC); MSHPP (CAP; DS)	2 ateliers: 3 264 000F et 2 tests: 24 000 000F à raison de 12 000 000 F par test	un plan d'intervention d'urgence élaboré et testé
			Redynamiser la Commission nationale de Gestion des risques chimiques (réunions de coordination)						Nombre de réunions
				Sous total 12					

URGENCES LIEES AUX RAYONNEMENTS

But	Objectifs	Résultats attendus	Activités	Calendrier d'Exécution			Responsable de Mise en œuvre	Coût (Milliers FCFA)	Indicateurs de Performance
				2012	2013	2014			
Améliorer la prise en charge des risques liés aux accidents nucléaires et aux situations d'urgence radiologique.	Etablir un plan multisectoriel d'urgence lié aux rayonnements dans le cadre du plan ORSEC.	un plan multisectoriel de gestion des risques liés aux rayonnements est opérationnel	Elaboration et validation du plan d'urgence (atelier)	X			ARSN	Budget	rapport de plan national finalisé et validé
			multiplication et diffusion du plan	X	X		ARSN	Budget	nombre d'exemplaires distribués
			tester l'opérationnalité du plan par des exercices de simulation		X		ARSN	Budget	exercices de simulation effectués
	mettre en place un système de surveillance des événements radiologiques	détection précoce et notification des événements radiologiques	Inventaire national des sources de rayonnements ionisants	X			ARSN	Budget	Carte nationale des pratiques (médecine, industrie, recherche...) et des sources de rayonnements associées aux pratiques est disponible
			renforcer la structure de surveillance en équipement de détection (dosimétrie)	X	X	X	ARSN	Budget	équipements disponibles
			formation du personnel chargé de la surveillance	X	X		ARSN	Budget	personnel formé pour la surveillance
			établir des normes et procédures de la surveillance	X			ARSN	Budget	manuels et procédures conçus

			Arrangements multilatéraux et bilatéraux dans le cadre de la convention sur l'Assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique.	X	X	X	ARSN	Budget	Signature des arrangements
	assurer une prise en charge appropriée des cas d'urgence liés aux rayonnements	les cas liés aux rayonnements sont correctement pris en charge	identifier les structures sanitaires chargées de la prise en charge des cas liés aux rayonnements	X			ARSN et MSHPP	Budget	structures de prise en charge des cas liés aux rayonnements identifiées
			Evaluer les besoins en équipements des structures de prise en charge des cas	X			ARSN et MSHPP	Budget	Document de l'évaluation des besoins disponible
			former le personnel sur la prise en charge des cas liés aux rayonnements	X	X		ARSN et MSHPP	Budget	Nombre de personnes formées
			Sous total 13						